

Правила сервісу «Інструментальна діагностика» (IR0-IR5)

ТЛУМАЧЕННЯ:

Коди пункту – пункт, що містить 5 знаків, та включає всі коди, які відносяться до цього пункту. (Наприклад: пункт 11503 включає коди: 11503-00, 11503-01, 11503-02. Правило стосується всіх кодів даного пункту).

Ефективний термін експлуатації обладнання – строк, до якого гарантовано безпечне застосування медичного обладнання з діагностичної візуалізації, яке не було модернізоване, із зазначенням року та місяця.

Максимальний продовжений термін експлуатації обладнання – строк, до якого гарантовано безпечне застосування медичного обладнання з діагностичної візуалізації, яке було модернізоване, із зазначенням року та місяця

Неконсультаційні послуги – послуги класу «Клінічні інструментальні дослідження» та всі класи сервісу «Процедури»

Послуги з діагностичної візуалізації – послуги, що відносяться до класів:

- Магнітно-резонансна томографія,
- Комп'ютерна томографія з контрастуванням,
- Комп'ютерна томографія без контрастування,
- Рентгенологічні дослідження,
- Ультразвукове дослідження.

ЗАГАЛЬНІ ПРАВИЛА (IR.0)

Номер правила	Правило	Дата запровадження/зміни/скасування
IR.1.01	Якщо в одному закладі одному пацієнту надається 2 або більше послуг з діагностичної візуалізації в той самий день, то на послугу з найвищим коригувальним коефіцієнтом застосовується коефіцієнт 1,0, на другу послугу (наступну з найвищим коригувальним коефіцієнтом) застосовується коефіцієнт 0,9, на третю послугу та наступні – коефіцієнт 0,8. У разі надання послуг з однаковим коригувальним коефіцієнтом, на першу послугу застосовується коефіцієнт 1,0, на другу послугу – коефіцієнт 0,9, на третю послугу та наступні – коефіцієнт 0,8	1.09.2025



IR.1.02	Якщо в одному закладі одному пацієнту надається 2 або більше послуг в той самий день за класом «Клінічні інструментальні дослідження», то на першу послугу застосовується коефіцієнт 1,0, на другу послугу застосовується коефіцієнт 0,9, на третю послугу та наступні – коефіцієнт 0,8.	
IR.1.03	Якщо лікар надає хоча б одну послугу з діагностичної візуалізації і хоча б одну консультацію тому самому пацієнту в той самий день, до будь-якої послуги з діагностичної візуалізації застосовується коефіцієнт 0,9	1.09.2025
IR.1.04	Якщо в одному закладі одному пацієнту в той самий день надається хоча б одна послуга діагностичної візуалізації і хоча б одна неконсультаційна послуга одному пацієнту в той самий день, то до будь-якої послуги з діагностичної візуалізації застосовується коефіцієнт 0,9	1.09.2025
IR.1.05	Якщо в одному закладі одному пацієнту в той самий день надається дві або більше послуг з групи 3 «Дослідження судин» сервісу «Ультразвукові дослідження» та одна або більше інших послуг діагностичної візуалізації у звіт на оплату потрапляє одна послуга УЗД судин.	1.09.2025
IR.1.06	Якщо в одному закладі одному пацієнту в той самий день надається дві або більше послуг МРТ (коди 90901-03, 90901-07, 90902-01, 90902-03, 90902-06) та одна або більше інших послуг з діагностичної візуалізації у звіт на оплату потрапляє одна послуга МРТ,	1.09.2025
IR.1.07	Якщо пацієнту надавалась діагностична послуга під анестезією, то у звіт на оплату потрапляє і діагностична послуга і анестезіологічне забезпечення в рамках сервісу «Процедури». Послуги з анестезіологічного забезпечення потрапляють у звіт на оплату при дотриманні таких умов: в правилах вказано, що діагностична послуга може потребувати анестезіологічного забезпечення або пацієнтам з діагнозом класу F, коли діагностичну послугу не можна надати без анестезіологічного забезпечення, або дітям до 10 років, коли діагностичну послугу не можна надати без анестезіологічного забезпечення.	1.09.2025

КЛАС «МАГНІТНО-РЕЗОНАНСНА ТОМОГРАФІЯ» (IR1)

(коди 90901-00, 90901-01, 90901-02, 90901-03, 90901-04, 90901-05, 90901-06, 90901-07, 90901-08, 90901-09, 90901-10, 90902-00, 90902-01, 90902-02, 90902-03, 90902-04, 90902-05, 90902-06, 90902-07)

Номер правила	Правило	Дата запровадження/зміни/скасування
IR.1.01	Дослідження потрапляє у звіт на оплату при дотриманні таких умов: (а) дослідження проведене на обладнанні, ефективний термін експлуатації якого становить до 10 років або максимальний продовжений термін експлуатації обладнання – до 20 років; (б) дослідження виконане за направленням лікаря-спеціаліста; (в) дослідження виконане лікарем, який пройшов навчання і відповідно до своїх посадових обов’язків має право проводити такі дослідження (код посади Р122); (г) лікар, який проводив дослідження, підготував висновок про дослідження, надав пацієнту паперовий або електронний його варіант, а також зображення в електронному форматі; (д) лікар, який проводив дослідження, зафіксував скорочений варіант висновку в ЕМЗ «Діагностичний звіт».	1.09.2025

КЛАС «МАГНІТНО-РЕЗОНАНСНА ТОМОГРАФІЯ» (IR.1.)**Група 1. ГОЛОВА ТА ШИЯ**

(коди 90901-00, 90901-01, 90901-02, 90902-00, 90901-09)

Номер правила	Правило	Дата запровадження/зміни/скасування
IR.1.01	Магнітно-резонансна томографія головного мозку (код 90901-00) Дослідження потрапляє у звіт на оплату при дотриманні таких умов: (а) проведене МРТ головного мозку, з контрастуванням (якщо проводиться) при таких станах: – пухлині головного мозку або менінгіті; або – запаленні головного мозку.	1.09.2025

	Дослідження може потребувати анестезіологічного забезпечення.	
IR.1.02	Магнітно-резонансна томографія головного мозку (код 90901-00) Дослідження потрапляє у звіт на оплату при дотриманні таких умов: (а) проведене МРТ головного мозку, з контрастуванням (якщо проводиться) особі віком до 16 років при таких станах: – судоми без встановленої причини; або – головний біль без встановленої причини, у т.ч. хронічний, при підозрі на значну патологію; або – патології навколоносових пазух, при якій консервативна терапія неефективна. Дослідження може потребувати анестезіологічного забезпечення.	1.09.2025
IR.1.03	Магнітно-резонансна томографія голови (код 90901-01) Дослідження потрапляє у звіт на оплату при дотриманні таких умов: (а) проведене МРТ голови, з контрастуванням (якщо проводиться) при таких станах: – пухлині основи черепа або орбіти; або – стереотаксичному скануванні головного мозку з встановленими опорними точками, виключно з метою планування стереотаксичного нейрохірургічного втручання. Дослідження може потребувати анестезіологічного забезпечення.	1.09.2025
IR.1.04	Магнітно-резонансна ангіографія голови або ший (код 90902-00) Дослідження потрапляє у звіт на оплату при дотриманні таких умов: (а) проведено магнітно-резонансну ангіографію голови або ший, включаючи МРТ сканування перед дослідженням (якщо проводиться), при таких станах: – пухлині головного мозку; – запаленні головного мозку; – пухлині основи черепа або орбіти; – стереотаксичному скануванні головного мозку з встановленими опорними точками, виключно з метою планування стереотаксичного нейрохірургічного втручання. Дослідження може потребувати анестезіологічного забезпечення.	1.09.2025

IR.1.05	Магнітно-резонансна томографія голови (код 90901-01) Дослідження потрапляє у звіт на оплату при дотриманні таких умов: (а) проведене МРТ голови, включаючи з контрастуванням (якщо проводиться) при таких станах: – акустичній невромі; – пухлинах гіпофізу; – токсичній, метаболічній чи ішемічній енцефалопатії; – демієлінізуючому захворюванні головного мозку; – вродженій ваді розвитку головного мозку або мозкових оболонок; – тромбозі венозного синуса; – черепній травмі; – епілепсії; – інсульті; – розшаруванні сонної або хребетної артерії; – внутрішньочерепній аневризмі; – внутрішньочерепній артеріовенозній мальформації. (б) пацієнту за останні 12 місяців виконано не більше 2 діагностичних досліджень (усього три рази за 12 місяців) з кодами: – 90901-01 Магнітно-резонансна томографія голови та/або – 90902-00 Магнітно-резонансна ангіографія голови або шиї. Дослідження може потребувати анестезіологічного забезпечення.	
IR.1.06	Магнітно-резонансна ангіографія голови або шиї (код 90902-00) Дослідження потрапляє у звіт на оплату при дотриманні таких умов: (а) проведено магнітно-резонансну ангіографію голови, включаючи МРТ сканування перед дослідженням (якщо проводиться), при таких станах: – акустичній невромі; – пухлинах гіпофізу; – токсичній, метаболічній чи ішемічній енцефалопатії; – демієлінізуючому захворюванні головного мозку; – вродженій ваді розвитку головного мозку або мозкових оболонок;	1.09.2025

	– тромбозі венозного синуса; – черепній травмі; – епілепсії; – розшаруванні сонної або хребетної артерії; – внутрішньочерепній аневризмі; – внутрішньочерепній артеріовенозній мальформації; (б) пацієнту за останні 12 місяців виконано не більше 2 діагностичних досліджень (усього три рази за 12 місяців) з кодами: – 90901-01 Магнітно-резонансна томографія голови та/або – 90902-00 Магнітно-резонансна ангіографія голови або шиї Дослідження може потребувати анестезіологічного забезпечення.	
IR.1.07	Магнітно-резонансна томографія шиї (код 90901-02) Дослідження потрапляє у звіт на оплату при дотриманні таких умов: (а) проведене МРТ голови та шиї або шиї, включаючи з контрастуванням, (якщо проводиться) при таких станах: – пухлинах ЦНС; – запаленнях ЦНС. Дослідження може потребувати анестезіологічного забезпечення.	1.09.2025
IR.1.08	Магнітно-резонансна ангіографія голови або шиї (код 90902-00) Дослідження потрапляє у звіт на оплату при дотриманні таких умов: (а) проведено магнітно-резонансну ангіографію, включаючи МРТ сканування (якщо проводиться) голови або шиї при таких станах: – пухлинах ЦНС; – запаленнях ЦНС. Дослідження може потребувати анестезіологічного забезпечення	1.09.2025
IR.1.09	Магнітно-резонансна томографія шиї (код 90901-02) Дослідження потрапляє у звіт на оплату при дотриманні таких умов: (а) проведено МРТ сканування судин голови та шиї для дослідження екстра- та/або внутрішньочерепного кровообігу при інсульті;	1.09.2025

	(б) пацієнту за останні 12 місяців з приводу даного захворювання виконано не більше 2 діагностичних досліджень (усього три рази за 12 місяців) з кодами: – 90902-00 Магнітно-резонансна ангіографія голови або шиї та/або – 90901-02 Магнітно-резонансна томографія шиї. Дослідження може потребувати анестезіологічного забезпечення.	
IR.1.10	Магнітно-резонансна ангіографія голови або шиї (код 90902-00) Дослідження потрапляє у звіт на оплату при дотриманні таких умов: (а) проведено магнітно-резонансну ангіографію судин голови та шиї для дослідження екстра- та/або внутрішньочерепного кровообігу при інсульті; (б) пацієнту за останні 12 місяців з приводу даного захворювання виконано не більше 2 діагностичних досліджень (усього три рази за 12 місяців) з кодами: – 90902-00 Магнітно-резонансна ангіографія голови або шиї та/або – 90901-02 Магнітно-резонансна томографія шиї. Дослідження може потребувати анестезіологічного забезпечення.	1.09.2025
IR1.11	Функціональна магнітно-резонансна томографія головного мозку (код 90901-09) Дослідження потрапляє у звіт на оплату при дотриманні таких умов: (а) проведено МРТ сканування головного мозку для дослідження активності мозку при планування операцій на мозку; (б) пацієнту за останні 12 місяців за даними показаннями виконано не більше 1 діагностичного дослідження з даним кодом (усього два рази за 12 місяців).	1.09.2025

КЛАС «МАГНІТНО-РЕЗОНАНСНА ТОМОГРАФІЯ» (IR.1.)

Група 2. ХРЕБЕТ

(коди: 90901-03, 90902-03)

Номер правила	Правило	Дата запровадження/зміни/скасування
IR1.12	Магнітно-резонансна томографія хребта (код 90901-03)	1.09.2025

	Дослідження потрапляє у звіт на оплату при дотриманні таких умов: (а) проведено МРТ, включаючи: з контрастуванням (якщо проводиться), однієї або більше суміжних (або несуміжних) ділянок хребта при таких станах: – пухлини або – запалення ЦНС. Дослідження може потребувати анестезіологічного забезпечення	
IR1.13	Магнітно-резонансна ангиографія хребта (код 90902-03) Дослідження потрапляє у звіт на оплату при дотриманні таких умов: (а) проведено МРА, включаючи: з контрастуванням (якщо проводиться), однієї або більше суміжних (або несуміжних) ділянок хребта при таких станах: – пухлини або – запалення ЦНС. Дослідження може потребувати анестезіологічного забезпечення	1.09.2025
IR1.14	Магнітно-резонансна томографія хребта (код 90901-03) Дослідження потрапляє у звіт на оплату при дотриманні таких умов: (а) проведено МРТ, включаючи з контрастуванням (якщо проводиться) хребта, включаючи з контрастуванням (якщо проводиться), дитині віком до 16 років при таких станах: – значній травмі або – неуточненому болю в шийі або спині з супутніми неврологічними симптомами, або – неуточненому болю в спині при підозрі на значну патологію. Дослідження може потребувати анестезіологічного забезпечення.	1.09.2025
IR.1.15	Магнітно-резонансна томографія хребта (код 90901-03) Дослідження потрапляє у звіт на оплату при дотриманні таких умов: (а) проведено МРТ сканування, включаючи з контрастуванням (якщо проводиться), однієї або більше суміжних (або несуміжних) ділянок хребта при таких станах: – демієлінізуючому захворюванні ЦНС; – вродженій ваді розвитку спинного мозку, кінського хвоста або мозкових оболонок; – вродженій або набутій сирингомієлії;	1.09.2025

	– шийній радикулопатії; – ішіасі; – стеноз спиніномозкового каналу; – попередній операції на хребті; – травми. б) пацієнту при вище вказаних станах за останні 12 місяців виконано не більше 2 діагностичних досліджень (усього три рази за 12 місяців) з кодами – 90901-03 Магнітно-резонансна томографія хребта та/або – 90902-03 Магнітно-резонансна ангіографія хребта. Дослідження може потребувати анестезіологічного забезпечення.	
IR1.16	Магнітно-резонансна ангіографія хребта (код 90902-03) Дослідження потрапляє у звіт на оплату при дотриманні таких умов: (а) проведено магнітно-резонансну ангіографію, однієї або більше суміжних (або несуміжних) ділянок хребта при таких станах: – демієлінізуючому захворюванні ЦНС; – мілопатії – вродженій ваді розвитку спинного мозку, кінського хвоста або мозкових оболонок; – вродженій або набутій сирингомієлії; – шийній радикулопатії; – ішіасі; – стеноз спиніномозкового каналу; – попередній операції на хребті; – травми. б) пацієнту при вище вказаних станах за останні 12 місяців виконано не більше 2 діагностичних досліджень (усього три рази за 12 місяців) з кодами – 90902-03 Магнітно-резонансна ангіографія хребта та/або – 90901-03 Магнітно-резонансна томографія хребта. Дослідження може потребувати анестезіологічного забезпечення.	1.09.2025
IR1.17	Манітно-резонансна томографія хребта (код 90901-03) Дослідження потрапляє у звіт на оплату при дотриманні таких умов: (а) проведено МРТ, включаючи з контрастуванням (якщо проводиться), шийного відділу хребта та плечового сплетення при таких станах:	1.09.2025

	– пухлині; – травм; – шийній радікулопатії; – попередній операції. б) пацієнту за останні 12 місяців виконано не більше 2 діагностичних досліджень з даним кодом (усього три рази за 12 місяців). Дослідження може потребувати анестезіологічного забезпечення.	
--	---	--

КЛАС «МАГНІТНО-РЕЗОНАНСНА ТОМОГРАФІЯ» (IR.1.)

Група 3. КІСТКОВО-М'ЯЗОВА СИСТЕМА

(код 90901-07, 90901-08, 90902-01, 90902-06, 90902-07)

Номер правила	Правило	Дата запровадження/зміни/скасування
IR1.18	Магнітно-резонансна томографія іншої ділянки тіла (код 90901-08) Дослідження потрапляє у звіт на оплату при дотриманні таких умов: (а) проведено МРТ, включаючи з контрастуванням (якщо проводиться), кістково-м'язової системи при таких станах: – пухлині, що виникає в кістці або кістково-м'язовій системі; – інфекція, що виникає в кістці або кістково-м'язовій системі; – остеонекрозі. Дослідження може потребувати анестезіологічного забезпечення.	1.09.2025
IR1.19	Магнітно-резонансна томографія кінцівки (код 90901-07) Дослідження потрапляє у звіт на оплату при дотриманні таких умов: (а) проведено МРТ, включаючи з контрастуванням (якщо проведено) коліна пацієнту віком до 16 років з приводу внутрішнього ураження суглоба. Дослідження може потребувати анестезіологічного забезпечення.	1.09.2025
IR1.20	Магнітно-резонансна томографія кінцівки (код 90901-07)	1.09.2025

	Дослідження потрапляє у звіт на оплату при дотриманні таких умов: (а) проведено МРТ, включаючи з контрастуванням (якщо проведено), коліна пацієнту віком від 16 до 49 років з: – підозрою на гострий розрив меніска; або – підозрою на гострий розрив передньої хрестоподібної зв'язки. Дослідження може потребувати анестезіологічного забезпечення.	
IR1.21	Магнітно-резонансна томографія кінцівки (код 90901-07) Дослідження потрапляє у звіт на оплату при дотриманні таких умов: (а) проведено МРТ, включаючи з контрастуванням (якщо проведено), кульшового суглоба для пацієнта віком до 16 років після рентгенологічного обстеження при: – підозрі на септичний артрит; або – підозрі на зміщення епіфіза головки стегнової кістки; або – підозрі на хворобу Пертеса. Дослідження може потребувати анестезіологічного забезпечення.	1.09.2025
IR1.22	Магнітно-резонансна томографія кінцівки (код 90901-07) Дослідження потрапляє у звіт на оплату при дотриманні таких умов: (а) проведено МРТ, включаючи з контрастуванням (якщо проведено), ліктя для пацієнта віком до 16 років після рентгенологічного обстеження при підозрі на значний перелом або відривну травму, що приведе до зміни тактики лікування. Дослідження може потребувати анестезіологічного забезпечення.	1.09.2025
IR1.23	Магнітно-резонансна томографія кінцівки (код 90901-07) Дослідження потрапляє у звіт на оплату при дотриманні таких умов: (а) проведено МРТ, включаючи з контрастуванням (якщо проведено), зап'ястя для пацієнта віком до 16 років після рентгенологічного обстеження при підозрі на значний перелом човноподібної кістки.	1.09.2025

	Дослідження може потребувати анестезіологічного забезпечення.	
IR1.24	Магнітно-резонансна томографія кінцівки (код 90901-07) Дослідження потрапляє у звіт на оплату при дотриманні таких умов: (а) проведено МРТ, включаючи з контрастуванням (якщо проводиться), кістково-м'язової системи при таких станах: – порушення функції кульшового суглобу або його опорних структур або – порушення функції колінного суглобу або його опорних структур, або – порушення функції плечевого суглобу або його опорних структур, або – порушення функції гомілковостопного суглоба та/або стопи або їх опорних структур, або – порушення функції зап'ястя та/або кисті чи його опорних структур, або – порушення функції ліктя або його опорних структур. б) пацієнту за останні 12 місяців виконано не більше 2 діагностичних досліджень з даним кодом (усього три рази за 12 місяців). Дослідження може потребувати анестезіологічного забезпечення.	1.09.2025
IR1.25	Магнітно-резонансна томографія іншої ділянки тіла (код 90901-08) Дослідження потрапляє у звіт на оплату при дотриманні таких умов: (а) проведено МРТ, включаючи з контрастуванням (якщо проводиться), кістково-м'язової системи при таких станах: – порушення функції одного або обох скронево-нижньощелепних суглобів або їх опорних структур. б) пацієнту за останні 12 місяців виконано не більше 2 діагностичних досліджень з даним кодом (усього три рази за 12 місяців). Дослідження може потребувати анестезіологічного забезпечення.	1.09.2025
IR1.26	Магнітно-резонансна томографія іншої ділянки тіла (код 90901-08)	1.09.2025

	Дослідження потрапляє у звіт на оплату при дотриманні таких умов: (а) проведено МРТ кістково-м'язової системи при хворобі Гоше; б) пацієнту за останні 12 місяців виконано не більше 1 діагностичного дослідження з даним кодом (усього два рази за 12 місяців)	
IR1.27	Магнітно-резонансна ангіографія кінцівок (коди 90902-01, 90902-06) Дослідження потрапляє у звіт на оплату при дотриманні таких умов: (а) проведено магнітно-резонансну ангіографію кінцівки при синдромі вродженої недостатності кінцівок (стані, при якому дитина народжується з кінцівкою, яка частково або повністю відсутня, або сформована аномально) для вирішення питання щодо оперативного втручання; (б) вік дитини до 16 років включно; (в) пацієнту за останні 12 місяців діагностичне дослідження з кодом 90902-01 або 90902-06 при даному стані не проводилося (усього один раз за 12 місяців). Дослідження може потребувати анестезіологічного забезпечення.	1.09.2025
IR1.28	Магнітно-резонансна ангіографія кінцівок або іншої ділянки тіла (коди 90901-07, 90901-08) Дослідження потрапляє у звіт на оплату при дотриманні таких умов: (а) проведено МРТ кінцівки або іншої ділянки тіла при таких станах: – післязапального або післятравматичному зрощенню епіфізарного хряща; або зрощенню зони росту; – хворобі Гоше; (б) вік дитини до 16 років включно; (в) пацієнту за останні 12 місяців виконано не більше 1 діагностичного дослідження з кодами 90901-07, 90901-08 при вище вказаних станах (усього два рази за 12 місяців). Дослідження може потребувати анестезіологічного забезпечення.	1.09.2025

КЛАС «МАГНІТНО-РЕЗОНАНСНА ТОМОГРАФІЯ» (IR.1.)
Група 4. СЕРЦЕВО-СУДИННА СИСТЕМА
(коди 90901-04, 90902-02)

Номер правила	Правило	Дата запровадження/зміни/скасування
IR1.29	Магнітно-резонансна томографія грудної клітки (код 90901-04) Дослідження потрапляє у звіт на оплату при дотриманні таких умов: (а) проведене МРТ, включаючи з контрастуванням (якщо проводиться), серцево-судинної системи, при таких станах: – вроджена хвороба серця або великої судини; – пухлина серця або великої судини; – аномалія грудної аорти. (б) пацієнту за останні 12 місяців виконано не більше 1 діагностичного дослідження з кодом 90901-04 та/або кодом 90902-02 при вище вказаному стані (усього два рази за 12 місяців). Дослідження може потребувати анестезіологічного забезпечення.	1.09.2025
IR1.30	Магнітно-резонансна ангіографія грудної клітки (код 90902-02) Дослідження потрапляє у звіт на оплату при дотриманні таких умов: (а) проведено магнітно-резонансну ангіографію серцево-судинної системи, включаючи МРТ сканування (якщо проводиться), при таких станах: – вроджена хвороба серця або великої(их) судини; – пухлина серця або великої(их) судини; – аномалія грудної аорти. (б) пацієнту за останні 12 місяців виконано не більше 1 діагностичного дослідження з кодом 90901-04 та/або кодом 90902-02 при вище вказаному стані (усього два рази за 12 місяців). Дослідження може потребувати анестезіологічного забезпечення.	1.09.2025
IR1.31	Магнітно-резонансна томографія грудної клітки (код 90901-04) Дослідження потрапляє у звіт на оплату при дотриманні таких умов: (а) проведене МРТ серцево-судинної системи, включаючи з контрастуванням (якщо проводиться), для оцінки структури та функції міокарда, що включає: – спеціальні проекції правого шлуночка; та	1.09.2025

	– 3D-волюметричну оцінку правого шлуночка; та – звітування про кінцево-діастолічний та кінцево-сistolічний об'єми, фракцію викиду та значення, індексовані за площею поверхні тіла (BSA); – дослідження виконано пацієнту, який звернувся із симптомами притаманними аритмогенній кардіоміопатії правого шлуночка; або результати дослідження пацієнта відповідають даному стану. (б) пацієнту за останні 12 місяців обстеження з кодом 90901-04 при даному стані не проводилося (одне дослідження за 12 місяців). Дослідження може потребувати анестезіологічного забезпечення.	
IR1.32	Магнітно-резонансна томографія грудної клітки (код 90901-04) Дослідження потрапляє у звіт на оплату при дотриманні таких умов: (а) проведено МРТ, включаючи з контрастуванням (якщо проводиться), серцево-судинної системи для оцінки структури та функції міокарда, що включає: – спеціальні проекції правого шлуночка; та – 3D-волюметричну оцінку правого шлуночка; та – звітування про кінцево-діастолічний; та кінцево-сistolічний об'єми, фракцію викиду та значення, індексовані за площею поверхні тіла (BSA); – дослідження виконано пацієнту, який немає симптомів щодо аритмогенної кардіоміопатії правого шлуночка та має одного або кількох родичів першого ступеня з підтвердженим діагнозом аритмогенної кардіоміопатії правого шлуночка (АРВК). (б) пацієнту за останні 36 місяців обстеження з кодом 90901-04 за даними показаннями не проводилося (одне дослідження за 36 місяців). Дослідження може потребувати анестезіологічного забезпечення.	1.09.2025
IR1.33	Магнітно-резонансна ангіографія грудної клітки (код 90902-02) Дослідження потрапляє у звіт на оплату при дотриманні таких умов: (а) проведено магнітно-резонансну ангіографію серцево-судинної системи при таких станах:	1.09.2025

	– судинній аномалії у пацієнта з попередньою анафілактичною реакцією на йодовмісну контрастну речовину; – обструкції верхньої порожнистої вени, нижньої порожнистої вени або внутрішньої клубової вени; або зовнішньої клубової вени. (б) пацієнту за останні 12 місяців виконано не більше 2 діагностичних досліджень з даним кодом (усього три рази за 12 місяців). Дослідження може потребувати анестезіологічного забезпечення.	
--	---	--

КЛАС «МАГНІТНО-РЕЗОНАНСНА ТОМОГРАФІЯ» (IR.1.)

Група 5. ЖИВІТ, ТАЗ

(Коди: 90901-05, 90901-06, 90902-04, 90902-05)

Номер правила	Правило	Дата запровадження/зміни/скасування
IR1.34	Магнітно-резонансна томографія черевної порожнини або таза (коди 90901-05 та 90901-06) Дослідження потрапляє у звіт на оплату при дотриманні таких умов: (а) проведене МРТ, включаючи з контрастуванням (якщо проводиться) при таких станах: – пухлина в області малого таза або черевної порожнини; – вроджена аномалія матки або аноректальної порожнини. (б) вік дитини до 16 років включно. Дослідження може потребувати анестезіологічного забезпечення.	1.09.2025
IR1.35	Магнітно-резонансна томографія грудної клітки (код 90901-04) Дослідження потрапляє у звіт на оплату при дотриманні таких умов: (а) проведене МРТ, включаючи з контрастуванням (якщо проводиться), медіастінума при таких станах: – пухлина медіастінума. (б) вік дитини до 16 років включно. Дослідження може потребувати анестезіологічного забезпечення.	1.09.2025

IR1.36	Магнітно-резонансна томографія черевної порожнини або таза (коди 90901-05 та 90901-06) Дослідження потрапляє у звіт на оплату при дотриманні таких умов: (а) проведене МРТ, включаючи з контрастуванням (якщо проводиться) сканування тазу або черевної порожнини та (б) пацієнтку направив спеціаліст-акушер-гінеколог; та (в) пацієнтка вагітна, термін гестації 18 тижнів або більше; та (г) є підозра на аномалію центральної нервової системи (ЦНС) плода; та (д) було проведено ультразвукове дослідження спеціалістом, який практикує за спеціальністю акушерство, при цьому діагноз був не визначений; або стан потребує подальшого обстеження. Дослідження може потребувати анестезіологічного забезпечення.	1.09.2025
IR1.37	Магнітно-резонансна томографія черевної порожнини (коди 90901-05) Дослідження потрапляє у звіт на оплату при дотриманні таких умов: (а) проведено МРТ черевної порожнини особі з злоякісною пухлиною наднирника, яка є резектабельною; (б) пацієнту за останні 12 місяців діагностичне дослідження з даним кодом при даному стані не проводилося (усього один раз за 12 місяців). Дослідження може потребувати анестезіологічного забезпечення.	1.09.2025
IR1.38	Магнітно-резонансна томографія таза (код 90901-06) Дослідження потрапляє у звіт на оплату при дотриманні таких умов: (а) проведено сканування передміхурової залози для виявлення раку, якщо у пацієнта є підозра на розвиток раку передміхурової залози через одну з наступних причин: – при пальцевому ректальному дослідженні виявлено підозру на рак передміхурової залози; або – у особи віком до 70 років принаймні два тести на простат-специфічний антиген (ПСА), проведені протягом 1-3 місяців, перевищують 3,0 нг/мл, а співвідношення вільного/загального ПСА менше 25%, або повторне ПСА перевищує 5,5 нг/мл; або	1.09.2025

	– у особи віком до 70 років, у якої ризик розвитку раку передміхурової залози зумовлений відповідним сімейним анамнезом щонайменше вдвічі перевищує середній ризик, принаймні два тести на ПСА, проведені протягом 1-3 місяців, перевищують 2,0 нг/мл, а співвідношення вільного/загального ПСА менше 25%; або – у особи віком 70 років або старше, принаймні два тести на ПСА, проведені протягом 1-3 місяців, перевищують 5,5 нг/мл, а співвідношення вільного/загального ПСА менше 25%. б) пацієнту за останні 12 місяців діагностичне дослідження з даним кодом за даними показаннями не проводилося (усього один раз за 12 місяців) Дослідження може потребувати анестезіологічного забезпечення. Примітка: Відповідний сімейний анамнез включає наявність раку простати у родича першого ступеня або наявність мутації гену BRCA 1 або BRCA 2.	
IR1.39	Магнітно-резонансна томографія таза (код 90901-06) Дослідження потрапляє у звіт на оплату при дотриманні таких умов: (а) проведено МРТ передміхурової залози пацієнту, який перебуває під активним спостереженням після підтвердженого діагнозу раку передміхурової залози за даними гістологічного дослідження. Дослідження може потребувати анестезіологічного забезпечення.	1.09.2025
IR1.40	Магнітно-резонансна томографія таза (коди 90901-06 та 90901-05) Дослідження потрапляє у звіт на оплату при дотриманні таких умов: (а) проведено МРТ, включаючи з контрастуванням (якщо проводиться), тазу та живота (якщо проводиться) для визначення стадії гістологічно діагностованого раку шийки матки стадії 1В або вище за шкалою FIGO пацієнтці, у якої діагностовано рак шийки матки стадії 1В або вище за шкалою FIGO; (б) оплата здійснюється лише один раз. Дослідження може потребувати анестезіологічного забезпечення.	1.09.2025
IR1.41	Магнітно-резонансна томографія таза (код 90901-06) Дослідження потрапляє у звіт на оплату при дотриманні таких умов:	1.09.2025

	(а) проведено МРТ, включаючи з контрастуванням (якщо проводиться), тазу при початковій стадії раку прямої кишки особі, в якій показаннями до обстеження є початкова стадія раку прямої кишки (включаючи рак ректосигмоподібного та аноректального відділів кишки). б) оплата здійснюється лише один раз. Дослідження може потребувати анестезіологічного забезпечення	
IR1.42	Магнітно-резонансна томографія черевної порожнини (код 90901-05) Дослідження потрапляє у звіт на оплату при дотриманні таких умов: (а) проведено МРТ, включаючи з контрастуванням (якщо проводиться), для оцінки хвороби Крона тонкої кишки особам з метою: – оцінки ступеня захворювання на момент первинного діагнозу хвороби Крона; – оцінки загострення/підозрюваних ускладнень відомої хвороби Крона; – оцінки відомої або підозрюваної хвороби Крона під час вагітності; – оцінки зміни терапії у пацієнтів з хворобою Крона. б) пацієнту за останні 12 місяців діагностичне дослідження з даним кодом при даному стані не проводилося (усього один раз за 12 місяців). Дослідження може потребувати анестезіологічного забезпечення.	1.09.2025
IR1.43	Магнітно-резонансна томографія черевної порожнини (код 90901-05) Дослідження потрапляє у звіт на оплату при дотриманні таких умов: (а) проведено МРТ підшлункової залози та жовчовивідних шляхів при підозрі на патологію жовчних шляхів або підшлункової залози; б) пацієнту за останні 12 місяців виконано не більше 2 діагностичних досліджень з даним кодом (усього три рази за 12 місяців). Дослідження може потребувати анестезіологічного забезпечення.	1.09.2025
IR1.44	Магнітно-резонансна томографія черевної порожнини (код 90901-05) Дослідження потрапляє у звіт на оплату при дотриманні таких умов:	1.09.2025

	(а) проведено МРТ з контрастною речовиною – багатофазне сканування печінки (включаючи відкладену візуалізацію, якщо вона виконується) – для характеристики або планування втручання у пацієнта з: – відомою колоректальною карциномою; та – відомими, підозрюваними або можливими метастазами в печінку; та – мас-утвореннями в печінці виявленими при попередній комп'ютерній томографії або ультразвуковому дослідженні. (б) пацієнту за останні 12 місяців діагностичне дослідження з даним кодом при даному стані не проводилося (усього один раз за 12 місяців). Дослідження може потребувати анестезіологічного забезпечення.	
IR1.45	Магнітно-резонансна томографія черевної порожнини (код 90901-05) Дослідження потрапляє у звіт на оплату при дотриманні таких умов: (а) проведено МРТ з контрастною речовиною – багатофазне сканування печінки (включаючи відкладену візуалізацію, якщо вона виконується) – для діагностики або визначення стадії у пацієнта з відомою або підозрюваною гепатоцелюлярною карциномою, та: – хронічним захворюванням печінки та печінковою недостатністю (клас А або В за класифікацією Чайлда-П'ю); та – виявленим ураженням печінки діаметром понад 10 мм. (б) пацієнту за останні 12 місяців діагностичне дослідження з даним кодом при даному стані не проводилося (усього один раз за 12 місяців). Дослідження може потребувати анестезіологічного забезпечення.	1.09.2025

КЛАС «МАГНІТНО-РЕЗОНАНСНА ТОМОГРАФІЯ» (IR.1.)

Група 6. ГРУДНА ЗАЛОЗА

(коди: 90901-10)

Номер правила	Правило	Дата запровадження/зміни/скасування

IR1.46	Магнітно-резонансна томографія молочної залози (код 90901-10) Дослідження потрапляє у звіт на оплату при дотриманні таких умов: (а) проведено МРТ сканування обох грудей для - виявлення раку, (б) особа не має симптомів та їй менше за 50 років; та (в) особа має показання до проведення дослідження, оскільки 1. вона має високий ризик розвитку раку молочної залози через одну з наступних причин: (А) 3 або більше родичів першого або другого ступеня споріднення з однієї сторони сім'ї, у яких діагностовано рак молочної залози або яєчників; (В) 2 або більше родичів першого або другого ступеня споріднення з однієї сторони сім'ї, у яких діагностовано рак молочної залози або яєчників, якщо будь-яка з наступних причин стосується принаймні одного з родичів: ○ діагностовано двосторонній рак молочної залози; ○ рак молочної залози почався до 40 років; ○ рак яєчників почався до 50 років; ○ діагностовано рак молочної залози та яєчників в той самий або різний час; ○ є родичем чоловічої статі, у якого діагностовано рак молочної залози. (С) один родич першого або другого ступеня споріднення, у якого діагностовано рак молочної залози у віці 45 років або молодше, плюс інший родич першого або другого ступеня споріднення з тієї ж сторони сім'ї з саркомою кісток або м'яких тканин у віці 45 років або молодше; або 2. Генетичне тестування виявило наявність генної мутації високого ризику раку молочної залози. 3. У пацієнта з вище вказаними факторами ризику (пункти 1-2) виявлено відхилення при проведенні даного діагностичного обстеження упродовж останніх 12 місяців. (г) пацієнту за останні 12 місяців діагностичне дослідження з цією метою не проводилося (усього один раз за 12 місяців). Дослідження може потребувати анестезіологічного забезпечення.	1.09.2025
----------------------	--	------------------

IR1.47	Магнітно-резонансна томографія молочної залози (код 90901-10) Дослідження потрапляє у звіт на оплату при дотриманні таких умов: (а) проведено МРТ обох грудей; (б) особі, в якій: – діагностовано метастатичний рак, обмежений регіональними лімфатичними вузлами; та – клінічне обстеження та звичайна візуалізація не дозволили виявити первинний рак. (в) пацієнту за останні 12 місяців діагностичне дослідження з цією метою не проводилося (усього один раз за 12 місяців). Дослідження може потребувати анестезіологічного забезпечення.	1.09.2025
IR1.48	Магнітно-резонансна томографія молочної залози (код 90901-10) Дослідження потрапляє у звіт на оплату при дотриманні таких умов: (а) проведено біопсію молочної залози під контролем МРТ, (б) особі, у якій виявлено підозріле ураження на МРТ, але не при звичайній візуалізації; та ураження не піддається біопсії під контролем звичайної візуалізації; (в) пацієнту за останні 12 місяців діагностичне дослідження з цією метою не проводилося (усього один раз за 12 місяців). Дослідження може потребувати анестезіологічного забезпечення.	1.09.2025
IR1.49	Магнітно-резонансна томографія молочної залози (код 90901-10) Дослідження потрапляє у звіт на оплату при дотриманні таких умов: (а) проведено МРТ, включаючи з контрастуванням (якщо проводилось) обох грудей; (б) особі, в якій: – у пацієнтки є ураження молочної залози; та – результати досліджень звичайної візуалізації не є остаточними щодо наявності раку молочної залози; та – біопсія не була можливою. Дослідження може потребувати анестезіологічного забезпечення.	1.09.2025

IR1.50	Магнітно-резонансна томографія молочної залози (код 90901-10) Дослідження потрапляє у звіт на оплату при дотриманні таких умов: (а) проведено МРТ, включаючи з контрастуванням (якщо проводилось), обох грудей; особі, в якої: – діагностовано рак молочної залози; та – існує розбіжність між клінічною оцінкою та традиційною оцінкою ступеня злоякісного новоутворення за допомогою візуалізації; та – результати МРТ молочної залози можуть змінити план лікування. Дослідження може потребувати анестезіологічного забезпечення.	1.09.2025
IR.1.51	Магнітно-резонансна томографія молочної залози (код 90901-10) Дослідження потрапляє у звіт на оплату при дотриманні таких умов: (а) проведено МРТ обох грудей особі, в якої є грудний імплантат; та діагностовано анапластичну великоклітинну лімфому. (б) особі діагностичне дослідження при даному стані раніше не проводилося (один раз протягом життя пацієнтки). Дослідження може потребувати анестезіологічного забезпечення.	1.09.2025

**КЛАСИ: «КОМП'ЮТЕРНА ТОМОГРАФІЯ З КОНТРАСТУВАННЯМ»
«КОМП'ЮТЕРНА ТОМОГРАФІЯ БЕЗ КОНТРАСТУВАННЯ»
(ІР.2.)**

Номер правила	Правило	Дата запровадження/зміни/скасування
ІР.2.01	Дослідження в межах цих класів потрапляє у звіт на оплату при дотриманні таких умов: (а) дослідження проведене на обладнанні, ефективний термін експлуатації якого становить до 10 років або максимальний продовжений термін експлуатації обладнання – до 15 років; (б) дослідження виконане за направленням лікаря-спеціаліста; (в) дослідження виконане лікарем, який пройшов навчання і відповідно до своїх посадових обов'язків має право проводити такі дослідження (код посади Р122); (г) лікар, який проводив дослідження, підготував висновок про дослідження, надав пацієнту паперовий або електронний його варіант, а також зображення в електронному форматі (д) лікар, який проводив дослідження, зафіксував скорочений варіант висновку в ЕМЗ «Діагностичний звіт»	1.09.2025
ІР.2.02	Дослідження з кодом з переліку (56220–56234, 56620–56630, 56219-00, 56220-00, 56221-00, 56223-00, 56224-00, 56225-00, 56226-00) потрапляє у звіт на оплату лише один раз, незалежно від того, чи потрібно одне або більше відвідувань для завершення послуги	1.09.2025

**КЛАСИ: «КОМП'ЮТЕРНА ТОМОГРАФІЯ З КОНТРАСТУВАННЯМ»
«КОМП'ЮТЕРНА ТОМОГРАФІЯ БЕЗ КОНТРАСТУВАННЯ» (ІР.2.)**

Група 1. ГОЛОВА

(коди 56001-00, 56007-00, 56010-00, 56010-01, 56010-02, 56010-03, 56013-00, 56013-01, 56013-02, 56013-03, 56016-00, 56016-01, 56016-02, 56016-03, 56016-04, 56016-05, 56016-06, 56016-07, 56022-00, 56022-01, 56022-02, 56028-00, 56028-01, 56028-02, 56030-00, 56036-00)

Номер правила	Правило	Дата запровадження/зміни/скасування
IR.2.01	Комп'ютерна томографія головного мозку (код 56001-00) Дослідження потрапляє у звіт на оплату при дотриманні таких умов: (а) проведене сканування головного мозку без внутрішньовенного контрастування; (б) упродовж 24 годин, які передують даному дослідженню, пацієнту не проводили дослідження з кодами: – 57001 Комп'ютерна томографія головного мозку, грудної клітки та черевної порожнини з внутрішньовенним контрастуванням або – 56013-02 Комп'ютерна томографія очної ямки та головного мозку. Дослідження може потребувати анестезіологічного забезпечення.	1.09.2025
IR.2.02	Комп'ютерна томографія головного мозку з внутрішньовенним контрастуванням (код 56007-00) Дослідження потрапляє у звіт на оплату при дотриманні таких умов: (а) проведене сканування мозку з внутрішньовенним контрастуванням і з будь-якими скануваннями мозку (якщо проводиться) перед введенням контрастного засобу; б) упродовж 24 годин, які передують даному дослідженню, пацієнту не проводили дослідження з кодами: – 57007-00 Комп'ютерна томографія головного мозку та грудної клітки з внутрішньовенним контрастуванням або, – 56013-03 Комп'ютерна томографія очної ямки та головного мозку з внутрішньовенним контрастуванням або, – 57007-01 Комп'ютерна томографія головного мозку, грудної клітки та черевної порожнини з внутрішньовенним контрастуванням або, – 56001-00 Комп'ютерна томографія головного мозку.	1.09.2025

	Дослідження може потребувати анестезіологічного забезпечення.	
IR.2.03	Комп'ютерна томографія гіпофізарної ямки (коди 56010-00, 56010-01, 56010-02, 56010-03) Дослідження потрапляє у звіт на оплату при дотриманні таких умов: (а) проведене сканування гіпофізарної ямки з внутрішньовенним контрастуванням або без нього, з можливим додатковим скануванням головного мозку; б) упродовж 24 годин, які передують даному дослідженню, пацієнту не проводили дослідження з кодами: – 57001-00 Комп'ютерна томографія головного мозку та грудної клітки або, – 57007-00 Комп'ютерна томографія головного мозку та грудної клітки з внутрішньовенним контрастуванням або, – 56001-00 Комп'ютерна томографія головного мозку або, – 56007-00 Комп'ютерна томографія головного мозку з внутрішньовенним контрастуванням. Дослідження може потребувати анестезіологічного забезпечення.	1.09.2025
IR.2.04	Комп'ютерна томографія очної ямки (коди пункту 56013-00, 56013-01, 56013-02, 56013-03) Дослідження потрапляє у звіт на оплату при дотриманні таких умов: (а) проведене сканування орбіт з внутрішньовенним контрастуванням або без нього, з можливим додатковим скануванням головного мозку; б) упродовж 24 годин, які передують даному дослідженню, пацієнту не проводили дослідження з кодами: – 57001-00 Комп'ютерна томографія головного мозку та грудної клітки або, – 57007-00 Комп'ютерна томографія головного мозку та грудної клітки з внутрішньовенним контрастуванням або, – 56001-00 Комп'ютерна томографія головного мозку або, – 56007-00 Комп'ютерна томографія головного мозку з внутрішньовенним контрастуванням. Дослідження може потребувати анестезіологічного забезпечення.	1.09.2025

IR.2.05	Комп'ютерна томографія середнього вуха, скроневої кістки та головного мозку (коди пункту 56016-00, 56016-01, 56016-02, 56016-03, 56016-04, 56016-05, 56016-06, 56016-07) Дослідження потрапляє у звіт на оплату при дотриманні таких умов: (а) проведено сканування середнього вуха та/або скроневої кістки та/або головного мозку, з внутрішньовенним контрастуванням або без нього, однобічне або двобічне; б) упродовж 24 годин, які передують даному дослідженню, пацієнту не проводили дослідження з кодами: – 57001-00 Комп'ютерна томографія головного мозку та грудної клітки або, – 57007-00 Комп'ютерна томографія головного мозку та грудної клітки з внутрішньовенним контрастуванням або, – 57007-01 Комп'ютерна томографія головного мозку, грудної клітки та черевної порожнини з внутрішньовенним контрастуванням або, – 56001-00 Комп'ютерна томографія головного мозку або, – 56007-00 Комп'ютерна томографія головного мозку з внутрішньовенним контрастуванням. Дослідження може потребувати анестезіологічного забезпечення.	1.09.2025
IR.2.06	Комп'ютерна томографія кісток лицевого черепа та придаткових пазух носа (коди 56022-00, 56022-01) Дослідження потрапляє у звіт на оплату при дотриманні таких умов: (а) проведено сканування пірамід кісток лицевого черепа та/або придаткових пазух носа без внутрішньовеного контрастування, з можливим скануванням головного мозку; б) упродовж 24 годин, які передують даному дослідженню, пацієнту не проводили дослідження з кодами: – 56028-00 Комп'ютерна томографія кісток лицевого черепа з внутрішньовенним контрастуванням, або – 56028-01 Комп'ютерна томографія придаткових пазух носа з внутрішньовенним контрастуванням, або	1.09.2025

	– 56028-02 Комп'ютерна томографія кісток лицевого черепа та придаткових пазух носа з внутрішньовенним контрастуванням. Дослідження може потребувати анестезіологічного забезпечення.	
IR.2.07	Комп'ютерна томографія кісток лицевого черепа та придаткових пазух носа з внутрішньовенним контрастуванням (коди пункту 56028) Дослідження потрапляє у звіт на оплату при дотриманні таких умов: (а) проведене сканування лицьових кісток та/або придаткових пазух носа з внутрішньовенним контрастуванням та з будь-якими скануваннями лицьових кісток та/або придаткових пазух носа до введення контрастного засобу, якщо виконано; (б) упродовж 24 годин, які передують даному дослідженню, пацієнту не проводили дослідження з кодами: – 56022-00 Комп'ютерна томографія кісток лицевого черепа, або – 56022-01 Комп'ютерна томографія придаткових пазух носа. Дослідження може потребувати анестезіологічного забезпечення.	1.09.2025
IR.2.08	Комп'ютерна томографія кісток лицевого черепа, придаткових пазух носа та головного мозку (код 56030-00) Дослідження потрапляє у звіт на оплату при дотриманні таких умов: (а) проведене сканування пірамід кісток лицевого черепа та/або придаткових пазух носа та головного мозку без внутрішньовеного контрастування; (б) упродовж 24 годин, які передують даному дослідженню, пацієнту не проводили дослідження з кодом пункту: – 56022-00 Комп'ютерна томографія кісток лицевого черепа або – 56022-01 Комп'ютерна томографія придаткових пазух носа, або – 56028-00 Комп'ютерна томографія кісток лицевого черепа з внутрішньовенним контрастуванням, або	1.09.2025

	– 56028-01 Комп'ютерна томографія придаткових пазух носа з внутрішньовенним контрастуванням, або – 56028-02 Комп'ютерна томографія кісток лицевого черепа та придаткових пазух носа з внутрішньовенним контрастуванням, або – 56036-00 Комп'ютерна томографія кісток лицевого черепа, придаткових пазух носа та головного мозку з внутрішньовенним контрастуванням. Дослідження може потребувати анестезіологічного забезпечення.	
IR.2.09	Комп'ютерна томографія кісток лицевого черепа, придаткових пазух носа та головного мозку з внутрішньовенним контрастуванням (код 56036-00) Дослідження потрапляє у звіт на оплату при дотриманні таких умов: (а) проведене сканування лицьових кісток, придаткових пазух носа із скануванням мозку, з внутрішньовенним контрастуванням, якщо: – сканування без контрасту вже було виконано; і – послуга необхідна через виявлені аномальні результати попереднього сканування. (б) упродовж 24 годин, які передують даному дослідженню, пацієнту не проводили дослідження з кодом. – 56030-00 Комп'ютерна томографія кісток лицевого черепа, придаткових пазух носа та головного мозку. Дослідження може потребувати анестезіологічного забезпечення.	1.09.2025

**КЛАСИ: «КОМП'ЮТЕРНА ТОМОГРАФІЯ З КОНТРАСТУВАННЯМ»
«КОМП'ЮТЕРНА ТОМОГРАФІЯ БЕЗ КОНТРАСТУВАННЯ» (IR.2.)**

Група 2. ШИЯ
(коди 56101-00, 56107-00)

Номер правила	Правило	Дата запровадження/зміни/скасування
IR.2.10	Комп'ютерна томографія м'яких тканин шиї (код 56101-00) Дослідження потрапляє у звіт на оплату при дотриманні таких умов:	1.09.2025

	(а) проведене сканування м'яких тканин ший, включаючи гортань, глотку, верхній стравохід і слинні залози (не пов'язано з шийним відділом хребта) без внутрішньовенного контрастування. Дослідження може потребувати анестезіологічного забезпечення.	
IR.2.11	Комп'ютерна томографія м'яких тканин ший з внутрішньовенним контрастуванням (код 56107-00) Дослідження потрапляє у звіт на оплату при дотриманні таких умов: (а) проведене сканування м'яких тканин ший, включаючи гортань, глотку, верхній стравохід і слинні залози (не пов'язано з шийним відділом хребта), з внутрішньовенним контрастуванням та з будь-якими скануваннями м'яких тканин ший перед введенням контрастного засобу, якщо виконано; (б) пацієнту, якому проводилося діагностичне дослідження, одночасно не надавалися послуги з кодом: – 56101-00 Комп'ютерна томографія м'яких тканин ший. Дослідження може потребувати анестезіологічного забезпечення.	1.09.2025

**КЛАСИ: «КОМП'ЮТЕРНА ТОМОГРАФІЯ З КОНТРАСТУВАННЯМ»
«КОМП'ЮТЕРНА ТОМОГРАФІЯ БЕЗ КОНТРАСТУВАННЯ» (IR.2.)**

Група 3. ХРЕБЕТ

(коди 56219-00, 56220-00, 56221-00, 56223-00, 56224-00, 56225-00, 56226-00, 56233-00, 56234-00)

Номер правила	Правило	Дата запровадження/зміни/скасування
IR.2.12	Комп'ютерна томографія хребта з внутрішньотекальним контрастуванням (код 56219-00) Дослідження потрапляє у звіт на оплату при дотриманні таких умов: (а) проведене сканування хребта, однієї або більше зон, із внутрішньотекальним контрастуванням, включаючи підготовку до введення контрастного засобу та будь-які асоційовані рентгенографії;	1.09.2025

	(б) пацієнту, якому проводилося діагностичне дослідження, одночасно не надавалися послуги з кодами: – 59724-00 Мієлографія; – 58100-00 Рентгенографія шийного відділу хребта, або – 58103-00 Рентгенографія грудного відділу хребта, або – 58106-00 Рентгенографія попереково-крижового відділу хребта, або – 58108-00 Рентгенографія хребта, 4 відділів, або – 58109-00 Рентгенографія крижово-куприкового відділу хребта, або – 58112-00 Рентгенографія хребта, 2 відділів, або – 58115-00 Рентгенографія хребта, 3 відділів. Дослідження з кодами може потребувати анестезіологічного забезпечення.	
IR.2.13	Комп'ютерна томографія хребта, шийний відділ (код 56220-00) Дослідження потрапляє у звіт на оплату при дотриманні таких умов: (а) проведене сканування хребта, шийного відділу, без внутрішньовенного контрастування. Дослідження може потребувати анестезіологічного забезпечення.	1.09.2025
IR.2.14	Комп'ютерна томографія хребта, грудний відділ (код 56221-00) Дослідження потрапляє у звіт на оплату при дотриманні таких умов: (а) проведене сканування хребта, грудного відділу, без внутрішньовенного контрастування. Дослідження може потребувати анестезіологічного забезпечення.	1.09.2025
IR.2.15	Комп'ютерна томографія хребта (код 56223-00) Дослідження потрапляє у звіт на оплату при дотриманні таких умов: (а) проведене сканування хребта, попереково-крижового відділу, без внутрішньовенного контрастування. Дослідження може потребувати анестезіологічного забезпечення.	1.09.2025
IR.2.16	Комп'ютерна томографія хребта з внутрішньовенним контрастуванням, шийний відділ (код 56224-00) Дослідження потрапляє у звіт на оплату при дотриманні таких умов:	1.09.2025

	(а) проведене сканування хребта, шийного відділу, з внутрішньовенним контрастуванням і з будь-якими скануваннями шийного відділу хребта (якщо проводиться) до введення контрастного засобу; (б) пацієнту, якому проводилося діагностичне дослідження, одночасно не надавалися послуги з кодом: – 56220-00 Комп'ютерна томографія хребта, шийний відділ. Дослідження може потребувати анестезіологічного забезпечення.	
IR.2.17	Комп'ютерна томографія хребта з внутрішньовенним контрастуванням, грудний відділ (код 56225-00) Дослідження потрапляє у звіт на оплату при дотриманні таких умов: (а) проведене сканування хребта, грудного відділу, з внутрішньовенним контрастуванням і з будь-якими скануваннями грудного відділу (якщо проводиться) до введення контрастного засобу; (б) пацієнту, якому проводилося діагностичне дослідження, одночасно не надавалися послуги з кодом: – 56221-00 Комп'ютерна томографія хребта, грудний відділ. Дослідження може потребувати анестезіологічного забезпечення.	1.09.2025
IR.2.18	Комп'ютерна томографія хребта з внутрішньовенним контрастуванням, попереково-крижовий відділ (код 56226-00) Дослідження потрапляє у звіт на оплату при дотриманні таких умов: (а) проведене сканування хребта, попереково-крижового відділу, з внутрішньовенним контрастуванням і з будь-якими скануваннями цього відділу (якщо проводиться) до введення контрастного засобу; (б) пацієнту, якому проводилося діагностичне дослідження, одночасно не надавалися послуги з кодом. – 56223-00 Комп'ютерна томографія хребта, попереково-крижовий відділ. Дослідження може потребувати анестезіологічного забезпечення.	1.09.2025
IR.2.19	Комп'ютерна томографія хребта, декілька відділів (код 56233-00) Дослідження потрапляє у звіт на оплату при дотриманні таких умов:	1.09.2025

	(а) проведене сканування хребта, двох зон, зазначених кодами 56220-00, 56221-00 та 56223-00, без внутрішньовенного контрастування; (б) у діагностичному звіті вказано коди сканованих зон хребта; (в) упродовж 24 годин, які передують дослідженню, пацієнту не проводили дослідження з кодами: – 56220-00 Комп'ютерна томографія хребта, шийний відділ; або, – 56221-00 Комп'ютерна томографія хребта, грудний відділ; або, – 56223-00 Комп'ютерна томографія хребта, попереково-крижовий відділ. Дослідження може потребувати анестезіологічного забезпечення.	
IR.2.20	Комп'ютерна томографія хребта з внутрішньовенним контрастуванням, декілька відділів (код 56234-00) Дослідження потрапляє у звіт на оплату при дотриманні таких умов: (а) проведене сканування хребта, двох зон, зазначених кодами 56224, 56225 та 56226, з внутрішньовенним контрастуванням і з будь-якими скануваннями цих зон (якщо проводиться) до введення контрастного засобу; (б) у діагностичному звіті вказано коди сканованих зон хребта; (в) упродовж 24 годин, які передують дослідженню, пацієнту не проводили дослідження з кодами: – 56220-00 Комп'ютерна томографія хребта, шийний відділ; або – 56221-00 Комп'ютерна томографія хребта, грудний відділ; або – 56223-00 Комп'ютерна томографія хребта, попереково-крижовий відділ; або – 56224-00, Комп'ютерна томографія хребта з внутрішньовенним контрастуванням, шийний відділ; або, – 56225-00 Комп'ютерна томографія хребта з внутрішньовенним контрастуванням, грудний відділ; або, – 56226-00 Комп'ютерна томографія хребта з внутрішньовенним контрастуванням, попереково-крижовий відділ або. Дослідження може потребувати анестезіологічного забезпечення.	1.09.2025

**КЛАСИ: «КОМП'ЮТЕРНА ТОМОГРАФІЯ З КОНТРАСТУВАННЯМ»
«КОМП'ЮТЕРНА ТОМОГРАФІЯ БЕЗ КОНТРАСТУВАННЯ» (ІР.2.)**

**Група 4. ГРУДНА КЛІТКА ТА ВЕРХНЯ ЧАСТИНА ЖИВОТА
(56301-00, 56301-01, 56307-00, 56307-01)**

Номер правила	Правило	Дата запровадження/зміни/скасування
ІР.2.21	Комп'ютерна томографія грудної клітки та/або черевної порожнини <i>(коди 56301-00, 56301-01)</i> Дослідження потрапляє у звіт на оплату при дотриманні таких умов: (а) проведено сканування грудної клітки, включаючи легені, середостіння, грудну стінку та плевру, з або без сканування верхньої частини живота, без внутрішньовенного контрастування; (б) упродовж 24 годин, які передують її наданню, пацієнту не проводили дослідження з кодами: – 57001-00 Комп'ютерна томографія головного мозку та грудної клітки, або – 57001-01 Комп'ютерна томографія головного мозку, грудної клітки та черевної порожнини, або – 57007-00 Комп'ютерна томографія головного мозку та грудної клітки з внутрішньовенним контрастуванням, або – 57007-01 Комп'ютерна томографія головного мозку, грудної клітки та черевної порожнини з внутрішньовенним контрастуванням. Дослідження може потребувати анестезіологічного забезпечення.	1.09.2025
ІР.2.22	Комп'ютерна томографія грудної клітки з внутрішньовенним контрастуванням <i>(коди пункту 56307-00)</i> Дослідження потрапляє у звіт на оплату при дотриманні таких умов: (а) проведено сканування грудної клітки, включаючи легені, середостіння, грудну стінку та плевру, з або без сканування верхньої частини живота, з внутрішньовенним контрастуванням і з будь-якими скануваннями грудної клітки, включаючи легені, середостіння, грудну стінку або плевру і верхню	1.09.2025

	частину живота (якщо проводиться) до введення внутрішньовенного контрасту; (б) упродовж 24 годин, які передують дослідженню, пацієнту не проводили дослідження з кодами: – 56807-00 Комп'ютерна томографія грудної клітки, черевної порожнини та таза з внутрішньовенним контрастуванням, або – 57007-00 Комп'ютерна томографія головного мозку та грудної клітки з внутрішньовенним контрастуванням, або – 57007-01 Комп'ютерна томографія головного мозку, грудної клітки та черевної порожнини з внутрішньовенним контрастуванням, або – 56301-00 Комп'ютерна томографія грудної клітки, або – 56301-01 Комп'ютерна томографія грудної клітки та черевної порожнини. Дослідження може потребувати анестезіологічного забезпечення.	
--	--	--

**КЛАСИ: «КОМП'ЮТЕРНА ТОМОГРАФІЯ З КОНТРАСТУВАННЯМ»
«КОМП'ЮТЕРНА ТОМОГРАФІЯ БЕЗ КОНТРАСТУВАННЯ» (ІР.2.)**

Група 5. ЖИВІТ
(56401-00, 56407-00, 56409-00, 56412-00)

Номер правила	Правило	Дата запровадження/зміни/скасування
ІР.2.23	Комп'ютерна томографія живота (код 56401-00) Дослідження потрапляє у звіт на оплату при дотриманні таких умов: (а) проведено сканування верхньої частини живота (від діафрагми до гребеня клубової кістки) без внутрішньовенного контрастування; (б) упродовж 24 годин, які передують дослідженню, пацієнту не проводили дослідження з кодами: – 56501-00 Комп'ютерна томографія живота та таза, або – 56801-00 Комп'ютерна томографія грудної клітки, живота та таза. Дослідження може потребувати анестезіологічного забезпечення.	1.09.2025

IR.2.24	Комп'ютерна томографія черевної порожнини з внутрішньовенним контрастуванням (код 56407-00) Дослідження потрапляє у звіт на оплату при дотриманні таких умов: (а) проведене сканування верхньої частини живота (від діафрагми до гребеня клубової кістки) з внутрішньовенним контрастуванням і з будь-якими скануваннями верхньої частини живота (якщо проводиться) до введення внутрішньовенного контрасту; (б) упродовж 24 годин, які передують дослідженню, пацієнту не проводили дослідження з кодами: – 56507-00 Комп'ютерна томографія живота та таза з внутрішньовенним контрастуванням (посиленням), або – 56807-00 Комп'ютерна томографія грудної клітки, живота та таза з внутрішньовенним контрастуванням (посиленням), або, – 57007-00 Комп'ютерна томографія головного мозку та грудної клітки з внутрішньовенним контрастуванням (посиленням), або, в) пацієнту, якому проводилося діагностичне дослідження, одночасно не надавалися послуги з кодом: – 56401-00 Комп'ютерна томографія живота. Дослідження може потребувати анестезіологічного забезпечення.	1.09.2025
IR.2.25	Комп'ютерна томографія таза (код 56409-00) Дослідження потрапляє у звіт на оплату при дотриманні таких умов: (а) проведене сканування тазу (від гребеня клубової кістки до лобкового симфізу) без внутрішньовенного контрастування; (б) пацієнту, якому проводилося діагностичне дослідження, одночасно не надавалися послуги з кодом: – 56501-00 Комп'ютерна томографія черевної порожнини та таза. Дослідження може потребувати анестезіологічного забезпечення.	1.09.2025
IR.2.26	Комп'ютерна томографія таза з внутрішньовенним контрастуванням (код 56412-00)	1.09.2025

	Дослідження потрапляє у звіт на оплату при дотриманні таких умов: (а) проведене сканування тазу (від гребеня клубової кістки до лобкового симфізу) з внутрішньовенним контрастуванням і з будь-якими скануваннями тазу (якщо проводиться) до введення внутрішньовенного контрасту; (б) упродовж 24 годин, які передують його проведенню, пацієнту не виконували дослідження з кодом: – 56507-00 Комп'ютерна томографія живота та таза з внутрішньовенним контрастуванням (посиленням); (в) пацієнту, якому проводилося діагностичне дослідження, одночасно не надавалися послуги з кодом: – 56409-00 Комп'ютерна томографія таза. Дослідження може потребувати анестезіологічного забезпечення.	
--	--	--

**КЛАСИ: «КОМП'ЮТЕРНА ТОМОГРАФІЯ З КОНТРАСТУВАННЯМ»
«КОМП'ЮТЕРНА ТОМОГРАФІЯ БЕЗ КОНТРАСТУВАННЯ» (IR.2.)**

Група 6. ЖИВІТ ТА ТАЗ
(56501-00, 56507-00)

Номер правила	Правило	Дата запровадження/зміни/скасування
IR.2.27	Комп'ютерна томографія черевної порожнини та таза (код 56501-00) Дослідження потрапляє у звіт на оплату при дотриманні таких умов: (а) проведене сканування верхньої частини живота та тазу без внутрішньовенного контрастування, не для віртуальної колоноскопії; (б) упродовж 24 годин, які передують його проведенню, пацієнту не виконували дослідження з кодами: – 56801-00 Комп'ютерна томографія грудної клітки, черевної порожнини та таза, або – 57001-01 Комп'ютерна томографія головного мозку, грудної клітки та черевної порожнини.	1.09.2025

	Дослідження може потребувати анестезіологічного забезпечення.	
IR.2.28	Комп'ютерна томографія живота та таза з внутрішньовенним контрастуванням (посиленням) (код 56507-00) Дослідження потрапляє у звіт на оплату при дотриманні таких умов: (а) проведене сканування верхньої частини живота та тазу з внутрішньовенним контрастом і з будь-якими скануваннями верхньої частини живота та тазу (якщо проводиться) до введення внутрішньовенного контрасту, не для віртуальної колоноскопії; б) пацієнту, якому проводилося діагностичне дослідження, одночасно не надавалися послуги з кодами: – 56501-00 Комп'ютерна томографія черевної порожнини та таза, або – 56409-00 Комп'ютерна томографія таза, або – 56401-00 Комп'ютерна томографія живота Дослідження може потребувати анестезіологічного забезпечення.	1.09.2025

**КЛАСИ: «КОМП'ЮТЕРНА ТОМОГРАФІЯ З КОНТРАСТУВАННЯМ»
«КОМП'ЮТЕРНА ТОМОГРАФІЯ БЕЗ КОНТРАСТУВАННЯ» (IR.2.)**

**Група 7. КІНЦІВКИ
(56619-00, 56625-00)**

Номер правила	Правило	Дата запровадження/зміни/скасування
IR.2.29	Комп'ютерна томографія кінцівки (код 56619-00) Дослідження потрапляє у звіт на оплату при дотриманні таких умов: (а) проведене сканування кінцівок, однієї або кількох областей без внутрішньовенного контрастування. Дослідження може потребувати анестезіологічного забезпечення	1.09.2025
IR.2.30	Комп'ютерна томографія кінцівки з внутрішньовенним контрастуванням (код 56625-00) Дослідження потрапляє у звіт на оплату при дотриманні таких умов: (а) проведене сканування кінцівок, однієї області або кількох областей з внутрішньовенним введенням	1.09.2025

	контрастування та з будь-якими скануваннями кінцівок (якщо проводиться) перед внутрішньовенним введенням контрасту; (б) пацієнту, якому проводилося діагностичне дослідження, одночасно не надавалися послуги з кодом: – 56619-00 Комп'ютерна томографія кінцівки Дослідження може потребувати анестезіологічного забезпечення	
--	--	--

**КЛАСИ: «КОМП'ЮТЕРНА ТОМОГРАФІЯ З КОНТРАСТУВАННЯМ»
«КОМП'ЮТЕРНА ТОМОГРАФІЯ БЕЗ КОНТРАСТУВАННЯ» (IR.2.)**

**Група 8. ГРУДНА КЛІТКА, ЖИВІТ, ТАЗ І ШИЯ
(56801-00, 56807-00)**

Номер правила	Правило	Дата запровадження/зміни/скасування
IR.2.31	Комп'ютерна томографія грудної клітки, черевної порожнини та таза (код 56801-00) Дослідження потрапляє у звіт на оплату при дотриманні таких умов: (а) проведене сканування грудної клітки, живота та тазу з або без сканування м'яких тканин шиї, без внутрішньовенного контрастування; (б) пацієнту, якому проводилося діагностичне дослідження, одночасно не надавалися послуги з кодами: – 56501-00 Комп'ютерна томографія черевної порожнини та таза, або – 56409-00 Комп'ютерна томографія таза, або – 56401-00 Комп'ютерна томографія живота, або – 56301-00 Комп'ютерна томографія грудної клітки; або – 56301-01 Комп'ютерна томографія грудної клітки та черевної порожнини. Дослідження може потребувати анестезіологічного забезпечення.	1.09.2025
IR.2.32	Комп'ютерна томографія грудної клітки, черевної порожнини та таза з внутрішньовенним контрастуванням (код 56807-00)	1.09.2025

	Дослідження потрапляє у звіт на оплату при дотриманні таких умов: (а) проведено сканування грудної клітки, живота та тазу з або без сканування м'яких тканин шиї, з внутрішньовенним контрастуванням і будь-якими скануваннями цих областей (якщо проводиться) до введення контрасту; (б) пацієнту, якому проводилося діагностичне дослідження, одночасно не надавалися послуги з кодами: – 56801-00 Комп'ютерна томографія грудної клітки, черевної порожнини та таза, або – 56307-00 Комп'ютерна томографія грудної клітки з внутрішньовенним контрастуванням, або – 56407-00 Комп'ютерна томографія черевної порожнини з внутрішньовенним контрастуванням, або – 56412-00 Комп'ютерна томографія таза з внутрішньовенним контрастуванням, або – 56507-00 Комп'ютерна томографія живота та таза з внутрішньовенним контрастуванням (посиленням). Дослідження може потребувати анестезіологічного забезпечення.	
--	--	--

**КЛАСИ: «КОМП'ЮТЕРНА ТОМОГРАФІЯ З КОНТРАСТУВАННЯМ»
«КОМП'ЮТЕРНА ТОМОГРАФІЯ БЕЗ КОНТРАСТУВАННЯ» (IR.2.)**

**Група 9. МОЗОК, ГРУДНА КЛІТКА ТА ВЕРХНЯ ЧАСТИНА ЖИВОТА
(57001-00, 57001-01, 57007-00, 57007-01)**

Номер правила	Правило	Дата запровадження/зміни/скасування
IR.2.33	Комп'ютерна томографія головного мозку, грудної клітки та черевної порожнини (коди пункту 57001-00, 57001-01) Дослідження потрапляє у звіт на оплату при дотриманні таких умов: (а) проведено сканування головного мозку та грудної клітки з або без сканування верхньої частини живота, без внутрішньовенного контрастування;	1.09.2025

	б) пацієнту, якому проводилося діагностичне дослідження, одночасно не надавалися послуги з кодами: – 56401-00 Комп'ютерна томографія живота, або – 56801-00 Комп'ютерна томографія грудної клітки, черевної порожнини та таза, або – 56501-00 Комп'ютерна томографія живота та таза, або – 56301-00 Комп'ютерна томографія грудної клітки, або – 56301-01 Комп'ютерна томографія грудної клітки та черевної порожнини, або – 56001-00 Комп'ютерна томографія головного мозку). Дослідження може потребувати анестезіологічного забезпечення.	
IR.2.34	Комп'ютерна томографія головного мозку, грудної клітки та черевної порожнини з внутрішньовенним контрастуванням (коди пункту 57007) Дослідження потрапляє у звіт на оплату при дотриманні таких умов: (а) проведене сканування головного мозку та грудної клітки з або без сканування верхньої частини живота, з внутрішньовенним контрастуванням і будь-якими скануваннями цих областей (якщо проводиться) до введення контрасту; б) пацієнту, якому проводилося діагностичне дослідження, одночасно не надавалися послуги з кодами: – 56007-00 Комп'ютерна томографія головного мозку з внутрішньовенним контрастуванням, або – 56307-00 Комп'ютерна томографія грудної клітки з внутрішньовенним контрастуванням, або – 56407-00 Комп'ютерна томографія черевної порожнини з внутрішньовенним контрастуванням, або – 56412-00 Комп'ютерна томографія таза з внутрішньовенним контрастуванням, або – 56507-00 Комп'ютерна томографія живота та таза з внутрішньовенним контрастуванням (посиленням) , або – 56807-00 Комп'ютерна томографія грудної клітки, черевної порожнини та таза з внутрішньовенним контрастуванням, або	1.09.2025

	– 57001-00 Комп'ютерна томографія головного мозку та грудної клітки, або – 57001-01 Комп'ютерна томографія головного мозку, грудної клітки та черевної порожнини. Дослідження може потребувати анестезіологічного забезпечення.	
--	---	--

**КЛАС «КОМП'ЮТЕРНА ТОМОГРАФІЯ БЕЗ КОНТРАСТУВАННЯ»
«КОМП'ЮТЕРНА ТОМОГРАФІЯ БЕЗ КОНТРАСТУВАННЯ» (IR.2.)**

**Група 10. ПЕЛЬВІМЕТРІЯ
(57201-00)**

Номер правила	Правило	Дата запровадження/зміни/скасування
IR.2.35	Пельвіметрія за допомогою комп'ютерної томографії (код 57201-00) Дослідження потрапляє у звіт на оплату при дотриманні таких умов: (а) проведено вимірювання розміру та діаметру таза за допомогою комп'ютерної томографії. Дослідження може потребувати анестезіологічного забезпечення.	1.09.2025

**КЛАС «КОМП'ЮТЕРНА ТОМОГРАФІЯ»
«КОМП'ЮТЕРНА ТОМОГРАФІЯ БЕЗ КОНТРАСТУВАННЯ» (IR.2.)**

**Група 11. СПІРАЛЬНА АНГІОГРАФІЯ
(57360-00)**

Номер правила	Правило	Дата запровадження/зміни/скасування
IR.2.36	Комп'ютерна томографія коронарних артерій (код 57360-00), Дослідження потрапляє у звіт на оплату при дотриманні таких умов: (а) проведено сканування коронарних артерій на сканері мінімум з 64 зрізами (або еквівалентному), пацієнту: – зі стабільними симптоми, що притаманні коронарній ішемії, який має низький або середній ризик розвитку ішемічної хвороби серця та є	1.09.2025

	покази для проведення коронарної ангіографії; або – якому потрібно виключити аномалію коронарної артерії або фістули; або – який готується до проведення некоронарної операції на серці. Дослідження може потребувати анестезіологічного забезпечення.	
--	---	--

**КЛАС «КОМП'ЮТЕРНА ТОМОГРАФІЯ БЕЗ КОНТРАСТУВАННЯ»
«КОМП'ЮТЕРНА ТОМОГРАФІЯ БЕЗ КОНТРАСТУВАННЯ» (IR.2.)**

**Група 12. КОНУСНО-ПРОМЕНЕВА КОМП'ЮТЕРНА ТОМОГРАФІЯ
(57362-00)**

Номер правила	Правило	Дата запровадження/зміни/скасування
IR.2.37	Комп'ютерна томографія скронево-нижньощелепного суглобу (код 57362-00) Дослідження потрапляє у звіт на оплату при дотриманні таких умов: (а) проведено сканування зубів та скронево-нижньощелепного суглоба (без контрастування) для діагностики та лікування таких станів: – переломи нижньої щелепи та зубоальвеолярної ділянки, або – ортодонтичні стани, або – ендодонтичні стани, або – пародонтальні стани, або – стани скронево-нижньощелепного суглоба. (б) застосовується не більше одного дослідження пацієнту на день. Дослідження може потребувати анестезіологічного забезпечення.	1.09.2025

КЛАС «РЕНТГЕНОЛОГІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ» (ІР.3.)

Номер правила	Правило	Дата запровадження/зміни/ скасування
ІР.3.01	Дослідження потрапляє у звіт на оплату при дотриманні таких умов: (а) дослідження проведене на обладнанні, що використовується у межах послуг, на які поширюються коди груп 1–8, 12, 15 даного класу, ефективний термін експлуатації якого становить до 15 років та максимальний продовжений термін експлуатації обладнання – до 20 років; (б) дослідження виконане за направленням лікаря-спеціаліста (усі дослідження цього класу) або сімейного лікаря для діагностичних послуг, визначених кодами 57506-00, 57506-01, 57506-02, 57506-03, 57506-04, 57512-00, 57512-01, 57512-02, 57512-03, 57518-00, 57518-01, 57518-02, 57518-03, 57518-04, 57524-00, 57524-01, 57524-02, 57524-03, 57524-04, 57700-00, 57706-00, 57712-00, 57715-00, 57903-00, 58500-00, 58506-00, 58521-01, 58524-00, 58524-01, 58527-00, 59300-00, 59300-01, 59303-00, 59303-01; (в) дослідження виконане лікарем, який пройшов навчання і відповідно до своїх посадових обов’язків має право проводити такі дослідження (код посади Р122); або рентген-лаборантом (посада Р169) для діагностичних послуг, визначених кодами 57506-00, 57506-01, 57506-02, 57506-03, 57506-04, 57512-00, 57512-01, 57512-02, 57512-03, 57518-00, 57518-01, 57518-02, 57518-03, 57518-04, 57524-00, 57524-01, 57524-02, 57524-03, 57524-04, 57700-00, 57706-00, 57712-00, 57715-00, 57901-00, 57903-00, 57906-00, 57909-00, 57912-00, 57915-00, 58521-00, 58521-01, 58524-00, 58524-01, 58527-00; (г) лікар, який проводив дослідження, підготував висновок про дослідження, надав пацієнту паперовий або електронний його варіант, а також зображення (знімки або в електронному форматі); (д) лікар, який проводив дослідження, зафіксував скорочений варіант висновку в ЕМЗ «Діагностичний звіт».	1.09.2025

КЛАС «РЕНТГЕНОЛОГІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ» (IR.3.)

Група 1. КІНЦІВКИ

(коди 57506-00, 57506-01, 57506-02, 57506-03, 57506-04, 57512-00, 57512-01, 57512-02, 57512-03, 57518-00, 57518-01, 57518-02, 57518-03, 57518-04, 57524-00, 57524-01, 57524-02, 57524-03, 57524-04)

Номер правила	Правило	Дата запровадження/зміни/скасування
IR.3.01	Дослідження однієї ділянки верхньої кінцівки (коди 57506-00, 57506-01, 57506-02, 57506-03, 57506-04) Дослідження цієї групи потрапляють у звіт на оплату при дотриманні таких умов: (а) проведено рентгенографію плечової кістки або ліктя, або передпліччя або зап'ястка або кисті.	1.09.2025
IR.3.02	Дослідження кількох ділянок верхньої кінцівки (коди 57512-00, 57512-01, 57512-02, 57512-03) Дослідження цієї групи потрапляють у звіт на оплату при дотриманні таких умов: (а) проведено рентгенографію кількох ділянок верхньої кінцівки; (б) пацієнту, якому проводилося діагностичне дослідження, одночасно не надавалися послуги з кодами: – 57512-00 Рентгенографія ліктя та плечової кістки разом з кодом 57506-00 Рентгенографія плечової кістки та/або 57506-01 Рентгенографія ліктя або – 57512-01 Рентгенографія ліктя та передпліччя разом з кодом 57506-01 Рентгенографія ліктя та/або 57506-02 Рентгенографія передпліччя, або – 57512-02 Рентгенографія кисті, зап'ястка та передпліччя разом з кодом 57506-02 Рентгенографія передпліччя та/або 57506-03 Рентгенографія зап'ястка та/або 57506-04 Рентгенографія кисті, або – 57512-03 Рентгенографія кисті та зап'ястка разом з кодом 57506-03 Рентгенографія зап'ястка та/або 57506-04 Рентгенографія кисті.	1.09.2025
IR.3.03	Дослідження однієї ділянки нижньої кінцівки (коди 57518-00, 57518-01, 57518-02, 57518-03, 57518-04)	1.09.2025

	Дослідження цієї групи потрапляють у звіт на оплату при дотриманні таких умов: (а) проведено рентгенографію стегнової кістки або коліна, або гомілки або гомілковостопного суглоба або стопи.	
IR.3.04	Дослідження кількох ділянок нижньої кінцівки (коди 57524-00, 57524-01, 57524-02, 57524-03) Дослідження цієї групи потрапляють у звіт на оплату при дотриманні таких умов: (а) проведено рентгенографію кількох ділянок верхньої кінцівки; (б) пацієнту, якому проводилося діагностичне дослідження, одночасно не надавалися послуги з кодами: – 57524-00 Рентгенографія стегнової кістки та коліна разом з кодом 57518-00 Рентгенографія стегнової кістки та/або 57518-01 Рентгенографія коліна або – 57524-01 Рентгенографія коліна та гомілки разом з кодом 57518-01 Рентгенографія коліна та/або 57518-02 Рентгенографія гомілки, або – 57524-02 Рентгенографія гомілки та гомілковостопного суглоба разом з кодом 57518-02 Рентгенографія гомілки та/або 57518-03 Рентгенографія гомілковостопного суглоба, або – 57524-03 Рентгенографія гомілки, гомілковостопного суглоба та стопи разом з кодом 57518-02 Рентгенографія гомілки та/або 57518-03 Рентгенографія гомілковостопного суглоба та/або 57518-04 Рентгенографія стопи, або – 57524-04 Рентгенографія гомілковостопного суглоба та стопи разом з кодом 57518-03 Рентгенографія гомілковостопного суглоба та/або 57518-04 Рентгенографія стопи.	1.09.2025

КЛАС «РЕНТГЕНОЛОГІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ» (IR.3.)

Група 2. ПЛЕЧЕ АБО ТАЗ

(коди 57700-00, 57706-00, 57712-00, 57715-00, 57721-00)

Номер правила	Правило	Дата запровадження/зміни/
---------------	---------	---------------------------

		скасування
IR.3.05	Рентгенографія ділянки плечового суглобу (коди 57700-00, 57706-00) Дослідження цієї групи потрапляють у звіт на оплату при дотриманні таких умов (а) проведено рентгенографію ключиці, плеча або лопатки; (б) у разі відсутності основного діагнозу пов'язаного з травми, при декількох обстеженнях одночасно, у звіт на оплату потрапляє одне дослідження; (б) пацієнту, якому проводилося діагностичне дослідження з кодом 57700-00 Рентгенографія плеча або лопатки, одночасно не надавалися послуги з кодом: – 59751-00 артрографія.	1.09.2025
IR.3.06	Рентгенографія кульшового суглоба (код 57712-00) Дослідження цієї групи потрапляють у звіт на оплату при дотриманні таких умов: (а) проведено рентгенографію кульшового суглоба; (б) пацієнту, якому проводилося діагностичне дослідження, одночасно не надавалися послуги з кодом: – 59751-00 артрографія.	1.09.2025
IR.3.07	Рентгенографія таза (код 57715-00) Дослідження цієї групи потрапляють у звіт на оплату при дотриманні таких умов: (а) проведено рентгенографію тазового поясу	1.09.2025
IR.3.08	Рентгенографія внутрішньої фіксації перелому стегнової кістки (код 57721-00) Дослідження цієї групи потрапляють у звіт на оплату при дотриманні таких умов: (а) проведено рентгенографію внутрішньої фіксації перелому стегнової кістки; (б) пацієнту, якому проводилося діагностичне дослідження, одночасно не надавалися послуги з кодом: – 57518-00 Рентгенографія стегнової кістки	1.09.2025

КЛАС «РЕНТГЕНОЛОГІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ» (IR.3.)

Група 3. ГОЛОВА

(57901-00, 57902-00, 57903-00, 57906-00, 57909-00, 57912-00, 57915-00, 57918-00, 57921-00, 57924-00, 57927-00, 57930-00, 57933-00, 57939-00, 57942-00, 57945-00, 57960-00, 90900-00)

Номер правила	Правило	Дата запровадження/зміни/скасування
IR.3.09	Рентгенографія черепа (код 57901-00) Дослідження потрапляє у звіт на оплату при дотриманні таких умов: (а) проведено рентгенографію черепа; (б) упродовж 24 годин, які передують його проведенню, пацієнту не виконували дослідження з кодом: – 57902-00 Краніометрія	1.09.2025
IR.3.10	Краніометрія (код 57902-00) Дослідження потрапляє у звіт на оплату при дотриманні таких умов: (а) проведено краніотомію; (б) упродовж 24 годин, які передують його проведенню, пацієнту не виконували дослідження з кодом: – 57901-00 Рентгенографія черепа	1.09.2025
IR.3.11	Рентгенографія іншої кістки лицевого черепа (код 57912-00) Дослідження потрапляє у звіт на оплату при дотриманні таких умов: (а) проведено рентгенографію іншої кістки лицевого черепа, включає виличну кістку, верхню щелепу, очну ямку.	1.09.2025
IR.3.12	Рентгенографія гортані (код 57945-00) Дослідження потрапляє у звіт на оплату при дотриманні таких умов: (а) проведено рентгенографію гортані, пряму та бічну проекцію дихальних шляхів і м'яких тканин ший; (б) упродовж 24 годин, які передують його проведенню, пацієнту не виконували дослідження з кодами: – 57939-00 Дослідження піднебінно-глоткового комплексу з рентгеноскопією або – 57942-00 Дослідження піднебінно-глоткового комплексу.	1.09.2025
IR.3.13	Енцефалографія (код 90900-00) Дослідження потрапляє у звіт на оплату при дотриманні таких умов: (а) проведено енцефалографію, включаючи пневмоцистернографію, пневмоенцефалографію.	1.09.2025

IR.3.14	Ортопантомографія (код 57960-00) Дослідження потрапляє у звіт на оплату при дотриманні таких умов: (а) проведено ортопантомографію для діагностики та/або лікування травм, інфекції, пухлин або вроджених чи хірургічних станів щелепно-лицевої області.	1.09.2025
----------------	---	-----------

КЛАС «РЕНТГЕНОЛОГІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ» (IR.3.)

Група 4. ХРЕБЕТ

(коди 58100-00, 58103-00, 58106-00, 58108-00, 58109-00, 58112-00, 58115-00)

Номер правила	Правило	Дата запровадження/зміни/скасування
IR.3.15	Рентгенографія хребта, 4 відділів (код 58108-00) Дослідження потрапляє у звіт на оплату при дотриманні таких умов: (а) проведено дослідження хребта: шийний, грудний, попереково-крижовий і крижово-куприковий відділи; (б) у діагностичному звіті вказано коди обстежень відділів хребта, виконаних за цим кодом.	1.09.2025
IR.3.16	Рентгенографія крижово-куприкового відділу хребта (код 58109-00) Дослідження потрапляє у звіт на оплату при дотриманні таких умов: (а) проведено дослідження хребет: крижово-куприковий відділ; (б) упродовж 24 годин, які передують його проведенню, пацієнту не виконували дослідження з кодом: – 58108-00 Рентгенографія хребта, 4 відділів.	1.09.2025
IR.3.17	Рентгенографія хребта, 2 відділи (код 58112-00) Дослідження потрапляє у звіт на оплату при дотриманні таких умов: (а) проведено дослідження хребет: 2 відділи, зазначених у кодах 58100-00 або 58103-00, або 58106-00 або 58109-00; (б) упродовж 24 годин, які передують його проведенню, пацієнту не виконували дослідження з кодом: – 58108-00 Рентгенографія хребта, 4 відділів;	1.09.2025

	(в) у діагностичному звіті вказано коди обстежень відділів хребта, виконаних за цим кодом.	
IR.3.18	Рентгенографія хребта, 3 відділів (код 58115-00) Дослідження потрапляє у звіт на оплату при дотриманні таких умов: (а) проведено дослідження хребет: 3 відділи, зазначених у кодах 58100-00, або 58103-00, або 58106-00 та або 58109-00; (б) упродовж 24 годин, які передують його проведенню, пацієнту не виконували дослідження з кодом: – 58108-00 Рентгенографія хребта, 4 відділів. (в) у діагностичному звіті вказано коди обстежень відділів хребта, виконаних за цим кодом.	1.09.2025

КЛАС «РЕНТГЕНОЛОГІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ» (IR.3.)

Група 5. КІСТКОВИЙ ВІК І ОБСТЕЖЕННЯ СКЕЛЕТУ

(коди 58300-00, 58306-00)

Номер правила	Правило	Дата запровадження/зміни/скасування
IR.3.19	Визначення кісткового віку зап'ястка та коліна за допомогою рентгенографії (код 58300-00) Дослідження потрапляє у звіт на оплату при дотриманні таких умов: (а) проведено дослідження зап'ястка та/або коліна для з'ясування кісткового віку; (б) упродовж 24 годин, які передують його проведенню, пацієнту не виконували дослідження з кодами: – 57518-01 Рентгенографія коліна або – 57506-03 Рентгенографія зап'ястка.	1.09.2025
IR.3.20	Рентгенографія всієї кісткової системи (код 58306-00) Дослідження потрапляє у звіт на оплату при дотриманні таких умов: (а) проведено дослідження всієї кісткової системи; (б) упродовж 24 годин, які передують його проведенню, пацієнту не виконували дослідження з кодом груп 1-5 цього класу.	1.09.2025

КЛАС «РЕНТГЕНОЛОГІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ» (IR.3.)

Група 6. ГРУДНА КЛІТКА

(коди 58500-00, 58506-00, 58509-00, 58521-00, 58521-01, 58524-00, 58524-01, 58527-00)

Номер правила	Правило	Дата запровадження/зміни/скасування
IR.3.21	Рентгенографія грудної клітки (код 58500-00) Дослідження потрапляє у звіт на оплату при дотриманні таких умов: (а) проведено рентгенологічне дослідження грудної клітки (легеневі поля) (б) пацієнту, якому проводилося діагностичне дослідження, одночасно не надавалися послуги з кодом: – 58506-00 Рентгенографія грудної клітки з рентгеноскопією.	1.09.2025
IR.3.22	Рентгенографія ребер, двобічна (код 58524-00) Дослідження потрапляє у звіт на оплату при дотриманні таких умов: (а) проведено рентгенологічне дослідження ребер, двобічне; (б) пацієнту, якому проводилося діагностичне дослідження, одночасно не надавалися послуги з кодами: – 58521-01 Рентгенографія ребер, однобічна або – 58524-01 Рентгенографія грудини та ребер, однобічна, або – 58527-00 Рентгенографія грудини та ребер, двобічна.	1.09.2025
IR.3.23	Рентгенографія грудини та ребер, двобічна (код 58527-00) Дослідження потрапляє у звіт на оплату при дотриманні таких умов: (а) проведено рентгенологічне дослідження грудини та ребер, двобічне (б) пацієнту, якому проводилося діагностичне дослідження, одночасно не надавалися послуги з кодами: – 58521-01 Рентгенографія ребер, однобічна або – 58524-01 Рентгенографія грудини та ребер, однобічна, або – 58524-00 Рентгенографія ребер, двобічна.	1.09.2025

КЛАС «РЕНТГЕНОЛОГІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ» (ІР.3.)

Група 7. СЕЧОВИВІДНІ ШЛЯХИ

(коди 58700-00, 58706-00, 58715-00, 58715-01, 58718-00, 58718-01, 58721-00, 90906-00)

Номер правила	Правило	Дата запровадження/зміни/скасування
ІР.3.24	Внутрішньовенна пієлографія (код 58706-00) Дослідження потрапляє у звіт на оплату при дотриманні таких умов: (а) проведено внутрішньовенну пієлографію, що включає просте рентгенологічне дослідження (якщо проводиться), або томографію (якщо проводиться); (б) пацієнту, якому проводилося діагностичне дослідження, одночасно не надавалися послуги з кодами: – 58700-00 Рентгенографія сечовивідних шляхів або – 56501-00 Комп'ютерна томографія черевної порожнини та таза.	1.09.2025
ІР.3.25	Пієлографія (коди 58715-00, 58715-01) Дослідження потрапляє у звіт на оплату при дотриманні таких умов: (а) проведено антеградну або ретроградну пієлографію, що включає просте рентгенологічне дослідження (якщо проводиться), з підготовкою та введенням контрасту; (б) пацієнту, якому проводилося діагностичне дослідження, одночасно не надавалися послуги з кодом: – 58700-00 Рентгенографія сечовивідних шляхів.	1.09.2025
ІР.3.26	Ретроградна цистографія або ретроградна уретрографія (коди пункту 58718) Дослідження потрапляє у звіт на оплату при дотриманні таких умов: (а) проведено ретроградну цистографію або ретроградну уретрографію, що включає звичайну рентгенографію сечовивідних шляхів (якщо проводиться), з підготовкою та введенням контрасту; (б) пацієнту, якому проводилося діагностичне дослідження, одночасно не надавалися послуги з кодом:	1.09.2025

	– 58700-00 Рентгенографія сечовивідних шляхів. Дослідження може потребувати анестезіологічного забезпечення.	
IR.3.27	Ретроградна мікційна цистоуретрографія (код 58721-00) Дослідження потрапляє у звіт на оплату при дотриманні таких умов: (а) проведено ретроградну міктуруючу цистоуретрографію, включаючи підготовку та введення контрасту. Дослідження може потребувати анестезіологічного забезпечення.	1.09.2025
IR.3.28	Рентгенографія уретероілеостоми з внутрішньовенним контрастуванням (екскреторна урографія при сформованій уретероілеостомі) (код 90906-00) Дослідження потрапляє у звіт на оплату при дотриманні таких умов: (а) проведено рентгенографію уретероілеостоми з внутрішньовенним контрастуванням (екскреторна урографія при сформованій уретероілеостомі).	1.09.2025

КЛАС «РЕНТГЕНОЛОГІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ» (IR.3.)

Група 8. ТРАВНИЙ ТРАКТ ТА ЖОВЧНА СИСТЕМА

(коди 58900-00, 58909-00, 58909-01, 58912-00, 58912-01, 58915-00, 58916-00, 58921-00, 58924-00, 58927-00, 58936-00, 58939-00)

Номер правила	Правило	Дата запровадження/зміни/скасування
IR.3.29	Рентгенографія черевної порожнини (код 58900-00) Дослідження потрапляє у звіт на оплату при дотриманні таких умов: (а) проведено просту рентгенографію черевної порожнини; (б) упродовж 24 годин, які передують його проведенню, пацієнту не виконували дослідження з кодами: – 58909 Рентгенографія глотки, стравоходу, шлунка або дванадцятипалої кишки з контрастною речовиною та скринінговою рентгенографією грудної клітки або	1.09.2025

	– 58912 Рентгенографія стравоходу, шлунка та дванадцятипалої кишки з контрастною речовиною, що доходить до ободової кишки, або – 58915 Рентгенографія тонкої кишки з контрастною речовиною.	
IR.3.30	Рентгенографія глотки, стравоходу, шлунка або дванадцятипалої кишки з контрастною речовиною (коди 58909-00, 58909-01) Дослідження потрапляє у звіт на оплату при дотриманні таких умов: (а) проведено рентгенографію глотки, стравоходу, шлунка та дванадцятипалої кишки з контрастною речовиною, з попередньою рентгенографією (якщо проводиться);, (б) упродовж 24 годин, які передують його проведенню, пацієнту не виконували дослідження з кодом: – 58912 Рентгенографія стравоходу, шлунка та дванадцятипалої кишки з контрастною речовиною, що доходить до ободової кишки; (в) пацієнту, якому проводилося діагностичне дослідження, одночасно не надавалися послуги з кодом: – 58900-00 Рентгенографія черевної порожнини.	1.09.2025
IR.3.31	Рентгенографія стравоходу, шлунка та дванадцятипалої кишки з контрастною речовиною, що доходить до ободової кишки (код 58912-00, 58912-01) Дослідження потрапляє у звіт на оплату при дотриманні таких умов: (а) проведено рентгенографію стравоходу, шлунка та дванадцятипалої кишки з контрастною речовиною, що доходить до ободової кишки черевної порожнини, з попередньою рентгенографією (якщо проводиться); (б) упродовж 24 годин, які передують його проведенню, пацієнту не виконували дослідження з кодами: – 58909-00 Рентгенографія глотки, стравоходу, шлунка або дванадцятипалої кишки з контрастною речовиною або – 58915-00 Рентгенографія тонкої кишки з контрастною речовиною; (в) пацієнту, якому проводилося діагностичне дослідження, одночасно не надавалися послуги з кодом:	1.09.2025

	– 58900-00 Рентгенографія черевної порожнини.	
IR.3.32	Рентгенографія тонкої кишки з контрастною речовиною (код 58915-00) Дослідження потрапляє у звіт на оплату при дотриманні таких умов: (а) проведено рентгенографію тонкої кишки з контрастною речовиною, з попередньою рентгенографією (якщо проводиться); (б) упродовж 24 годин, які передують його проведенню, пацієнту не виконували дослідження з кодом: – 58912 Рентгенографія стравоходу, шлунка та дванадцятипалої кишки з контрастною речовиною, що доходить до ободової кишки; (в) пацієнту, якому проводилося діагностичне дослідження, одночасно не надавалися послуги з кодом: – 58900-00 Рентгенографія черевної порожнини.	1.09.2025
IR.3.33	Контрастна клізма тонкої кишки (код 58916-00) Дослідження потрапляє у звіт на оплату при дотриманні таких умов: (а) проведено рентгенографію тонкої кишки з дуоденальною інтубацією і введенням контрасту; б) пацієнту, якому проводилося діагностичне дослідження, одночасно не надавалися послуги з кодами: – 58900-00 Рентгенографія черевної порожнини або – 58912-00 Рентгенографія стравоходу, шлунка та дванадцятипалої кишки з контрастною речовиною, що доходить до ободової кишки, або – 58915-00 Рентгенографія тонкої кишки з контрастною речовиною. Дослідження може потребувати анестезіологічного забезпечення	1.09.2025
IR.3.34	Інша контрастна клізма (код 58921-00) Дослідження потрапляє у звіт на оплату при дотриманні таких умов: (а) проведено дослідження з повітряно-контрастною барієвою клізмою, з попередньою рентгенографією (якщо проводиться); б) пацієнту, якому проводилося діагностичне дослідження, одночасно не надавалися послуги з кодами:	1.09.2025

	– 58900-00 Рентгенографія черевної порожнини або – 58912-00 Рентгенографія стравоходу, шлунка та дванадцятипалої кишки з контрастною речовиною, що доходить до ободової кишки, або – 58915-00 Рентгенографія тонкої кишки з контрастною речовиною.	
IR.3.35	Холецистографія (код 58924-00) Дослідження потрапляє у звіт на оплату при дотриманні таких умов: (а) проведено холецистографію, з попередньою рентгенографією (якщо проводиться), з підготовкою та введенням контрасту; б) пацієнту, якому проводилося діагностичне дослідження, одночасно не надавалися послуги з кодами: – 58927-00 Пряма холангіографія, післяопераційна або – 58900-00 Рентгенографія черевної порожнини.	1.09.2025
IR.3.36	Пряма холангіографія, післяопераційна (код 58927-00) Дослідження потрапляє у звіт на оплату при дотриманні таких умов: (а) проведено пряму холангіографію з підготовкою та введенням контрасту; б) пацієнту, якому проводилося діагностичне дослідження, одночасно не надавалися послуги з кодом: – 58924-00 Холецистографія.	1.09.2025
IR.3.37	Інфузійна холангіографія (код 58936-00) Дослідження потрапляє у звіт на оплату при дотриманні таких умов: (а) проведено інфузійну холеографію, з попередньою рентгенографією або без неї, з підготовкою та введенням контрасту, з томографією або без неї; б) пацієнту, якому проводилося діагностичне дослідження, одночасно не надавалися послуги з кодом: – 58900-00 Рентгенографія черевної порожнини.	1.09.2025
IR.3.38	Дефекографія (код 58939-00) Дослідження потрапляє у звіт на оплату при дотриманні таких умов: (а) проведено флюороскопічне дослідження кишечника для оцінки функції тазового дна під час м'язових скорочень та дефекації.	1.09.2025

КЛАС «РЕНТГЕНОЛОГІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ» (IR.3.)

Група 9. ГРУДНІ ЗАЛОЗИ

(коди 59300-00, 59300-01, 59303-00, 59303-01, 59306-00, 59309-00)

Номер правила	Правило	Дата запровадження/зміни/скасування
IR.3.39	Рентгенографія молочної залози, двобічна (коди 59300-00, 59300-01)) Дослідження потрапляє у звіт на оплату при дотриманні таких умов: (а) проведено мамографію обох молочних залоз; (б) упродовж 24 годин, які передують його проведенню, пацієнту не виконували дослідження з кодами: – 59303-00 Рентгенографія молочної залози, однобічна або – 59303-01 Рентгенографія молочної залози з термографією, однобічна.	1.09.2025
IR.3.40	Рентгенографія молочної залози, однобічна (коди 59303-00, 59303-01) Дослідження потрапляє у звіт на оплату при дотриманні таких умов: (а) проведено мамографію однобічну; (б) упродовж 24 годин, які передують її проведенню, пацієнту не виконували дослідження з кодом: – 59300-00 Рентгенографія молочної залози, двобічна.	1.09.2025
IR.3.41	Дуктографія молочної залози, однобічна (код 59306-00) Дослідження потрапляє у звіт на оплату при дотриманні таких умов: (а) проведено дуктографію молочної залози, однобічну; (б) упродовж 24 годин, які передують її проведенню, пацієнту не виконували дослідження з кодом: – 59309-00 Дуктографія молочної залози, двобічна; (в) особі, якій проводилося діагностичне дослідження, одночасно не надавалися послуги з кодами: – 59300-00 Рентгенографія молочної залози, двобічна або	1.09.2025

	– 59303-00 Рентгенографія молочної залози, однобічна Не використовується для скринінгу.	
IR.3.42	Дуктографія молочної залози, двобічна (код 59309-00) Дослідження потрапляє у звіт на оплату при дотриманні таких умов: (а) проведено дуктографію молочної залози двобічну; (б) упродовж 24 годин, які передують її проведенню, пацієнту не виконували дослідження з кодом: – 59306-00 Дуктографія молочної залози, однобічна; (в) особі, якій проводилося діагностичне дослідження, одночасно не надавалися послуги з кодами: – 59300-00 Рентгенографія молочної залози, двобічна або – 59303-00 Рентгенографія молочної залози, однобічна. Не використовується для скринінгу	1.09.2025

КЛАС «РЕНТГЕНОЛОГІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ» (IR.3.)

Група 10. РЕНТГЕНОГРАФІЧНЕ ОБСТЕЖЕННЯ ІЗ ЗАСТОСУВАННЯМ КОНТРАСТУВАННЯ

(коди 59700-00, 59703-00, 59712-00, 59715-00, 59718-00, 59724-00, 59733-00, 59736-00, 59739-00, 59739-01, 59739-02, 59739-03, 59751-00, 59754-00, 59760-00, 59763-00, 90906-00)

Номер правила	Правило	Дата запровадження/зміни/скасування
IR.3.43	Дискографія (код 59700-00) Дослідження потрапляє у звіт на оплату при дотриманні таких умов: (а) проведено дослідження диску(ів) хребта, з попередніми оглядовими знімками або без них, з підготовкою та введенням контрасту; (б) особі, якій проводилося діагностичне дослідження, одночасно не надавалися послуги з кодами групи 4 даного класу. Дослідження може потребувати анестезіологічного забезпечення	1.09.2025
IR.3.44	Дакріоцистографія (код 59703-00) Дослідження потрапляє у звіт на оплату при дотриманні таких умов:	1.09.2025

	(а) проведено, дакріоцистографію однобічну, з попередніми оглядовими знімками або без них, з підготовкою та введенням контрасту.	
IR.3.45	Гістеросальпінгографія (код 59712-00) Дослідження потрапляє у звіт на оплату при дотриманні таких умов: (а) проведено гістеросальпінгографію з попередніми оглядовими знімками або без них, з підготовкою та введенням контрасту; (б) особі, якій проводилося діагностичне дослідження, одночасно не надавалися послуги з кодом: – 57715-00 Рентгенографія таза; Дослідження може потребувати анестезіологічного забезпечення	1.09.2025
IR.3.46	Бронхографія (код 59715-00) Дослідження потрапляє у звіт на оплату при дотриманні таких умов: (а) проведено бронхографію, однобічну, з попередніми оглядовими знімками або без них, з підготовкою та введенням контрасту; (б) особі, якій проводилося діагностичне дослідження, одночасно не надавалися послуги з кодами групи 6 даного класу. Дослідження може потребувати анестезіологічного забезпечення	1.09.2025
IR.3.47	Флебографія (код 59718-00) Дослідження потрапляє у звіт на оплату при дотриманні таких умов: (а) проведено флебографію, однобічну, з попередніми оглядовими знімками або без них, з підготовкою та введенням контрасту; (б) особі, якій проводилося діагностичне дослідження, одночасно не надавалися послуги з кодами групи 1 даного класу. Дослідження може потребувати анестезіологічного забезпечення (сервіс «Процедури»)	1.09.2025
IR.3.48	Мієлографія (код 59724-00) Дослідження потрапляє у звіт на оплату при дотриманні таких умов: (а) проведено мієлографію, одна або більше ділянок, з попередніми оглядовими знімками або без них, з підготовкою та введенням контрасту; б) упродовж 24 годин, які передують його проведенню, пацієнту не виконували дослідження з кодом:	1.09.2025

	– 56219 Комп'ютерна томографія хребта з внутрішньотекальним контрастуванням (посиленням); в) особі, якій проводилося діагностичне дослідження, одночасно не надавалися послуги з кодами групи 4 даного класу. Дослідження може потребувати анестезіологічного забезпечення	
IR.3.49	Рентгенографія слинної залози з штучним контрастуванням (код 59733-00) Дослідження потрапляє у звіт на оплату при дотриманні таких умов: (а) проведено сіалографію, однобічну, підготовкою та введенням контрасту; (б) упродовж 24 годин, які передують його проведенню, пацієнту не виконували дослідження з кодом: – 57918 Рентгенографія слинної залози.	1.09.2025
IR.3.50	Вазо-епідидимографія (код 59736-00) Дослідження потрапляє у звіт на оплату при дотриманні таких умов: (а) проведено вазо-епідидимографію	1.09.2025
IR.3.51	Рентгенографія венозних синусів (коди 59739-00) Дослідження потрапляє у звіт на оплату при дотриманні таких умов: (а) проведено синограму або фістулограму (рентгенографію венозних синусів грудної стінки або черевної стінки або заочеревинного простору), однієї або більше ділянок, з попередніми оглядовими знімками або без них, з підготовкою та введенням контрасту; в) особі, якій проводилося діагностичне дослідження, одночасно не надавалися послуги з кодами: – 58500-00 Рентгенографія грудної клітки або – 58900-00 Рентгенографія черевної порожнини.	1.09.2025
IR.3.52	Артрографія (код 59751-00) Дослідження потрапляє у звіт на оплату при дотриманні таких умов: (а) проведено артрографію, всі суглоби, за винятком фасеткових суглобів хребта, дослідження з одиночним або подвійним контрастуванням (рентгеноконтрастування та/або рентгенопрозорої речовини (зазвичай повітря)), з попередніми	1.09.2025

	оглядовими знімками або без них, з підготовкою та введенням контрасту; (б) упродовж 24 годин, які передують його проведенню, пацієнту не виконували дослідження з кодами: – 57712-00 Рентгенографія кульшового суглоба або – 57700-00 Рентгенографія плеча або лопатки; в) особі, якій проводилося діагностичне дослідження, одночасно не надавалися послуги з кодами групи 1 даного класу.	
IR.3.53	Лімфангіографія (код 59754-00) Дослідження потрапляє у звіт на оплату при дотриманні таких умов: (а) проведено лімфангіографію, однобічну або двобічну, з попередніми оглядовими знімками та подальшою рентгенографією, а також з підготовкою та введенням контрастування.	1.09.2025
IR.3.54	Перітонеографія (код 59760-00) Дослідження потрапляє у звіт на оплату при дотриманні таких умов: (а) проведено перітонеографію, одна або обидві сторони, з попередніми оглядовими знімками та подальшою рентгенографією, а також з підготовкою та введенням контрастування; (б) пацієнту, якому проводилося діагностичне дослідження, одночасно не надавалися послуги з кодом: – 58900-00 Рентгенографія черевної порожнини.	1.09.2025
IR.3.55	Інсуфляція повітря під час рентгеноскопії (код 59763-00) Дослідження потрапляє у звіт на оплату при дотриманні таких умов: (а) проведено інсуфляцію повітря під час відео-флюороскопічної візуалізації, включаючи оглядові знімки.	1.09.2025

КЛАС «РЕНТГЕНОЛОГІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ» (IR.3.)

Група 11. АНГІОГРАФІЯ

(коди 59970-00, 59970-02, 59970-03, 59970-04)

Номер правила	Правило	Дата запровадження/зміни/скасування
IR.3.56	Ангіографія та артеріографія (коди пункту 59970-00, 59970-02, 59970-03, 59970-04,) Дослідження потрапляє у звіт на оплату при дотриманні таких умов: (а) проведено ангіографію та/або цифрову субтракційну ангіографію з флюороскопією, одна або більше ділянок, з попередніми оглядовими знімками або без них, з підготовкою та введенням контрасту; (б) пацієнту, якому проводилося діагностичне дослідження, одночасно не надавалися послуги з іншими кодами пункту 59970. Дослідження може потребувати анестезіологічного забезпечення.	1.09.2025

КЛАС «РЕНТГЕНОЛОГІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ» (IR.3.)

Група 12. ФЛЮОРОСКОПІЧНЕ ОБСТЕЖЕННЯ

(коди 60503-00)

Номер правила	Правило	Дата запровадження/зміни/скасування
IR.3.57	Рентгеноскопія (код 60503-00) Дослідження потрапляє у звіт на оплату при дотриманні таких умов: (а) проведено флюороскопічне дослідження (б) пацієнту, якому проводилося діагностичне дослідження, одночасно не надавалися послуги з рентгенологічного дослідження.	1.09.2025

КЛАС «УЛЬТРАЗВУКОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ» (ІР.4.)

Номер правила	Правило	Дата запровадження/зміни/скасування
ІР.4.01	Дослідження потрапляє у звіт на оплату при дотриманні таких умов: (а) дослідження проведене на обладнанні, ефективний термін експлуатації якого становить до 10 років, та максимальний продовжений термін експлуатації обладнання – до 15 років; (б) дослідження виконане за направленням лікаря-спеціаліста або сімейного лікаря (крім кодів 55030-00 та 55048-00); (в) дослідження виконане лікарем, який пройшов навчання і відповідно до своїх посадових обов'язків має право проводити такі дослідження; (г) лікар, який проводив дослідження, підготував висновок про дослідження, надав пацієнту паперовий або електронний його варіант; (д) лікар, який проводив дослідження, зафіксував скорочений варіант висновку в ЕМЗ «Діагностичний звіт».	1.09.2025

КЛАС «УЛЬТРАЗВУКОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ» (ІР.4.)

Група 1. ЗАГАЛЬНЕ УЗД

(коди 55028-00, 55030-00, 55032-00, 55036-00, 55038-00, 55048-00, 55065-00, 55070-00, 55076-00, 55084-00)

Номер правила	Правило	Дата запровадження/зміни/скасування
ІР.4.01	УЗД черевної порожнини (код 55036-00) Дослідження потрапляє у звітність на оплату при дотриманні таких умов: (а) виконане дослідження черевної порожнини, включаючи сканування сечовивідних шляхів, якщо виконується; (б) упродовж 24 годин, які передують його проведенню, пацієнту не виконували дослідження з кодами:	1.09.2025

	– 55038-00 Ультразвукове дослідження сечовивідних шляхів або – 55065-00 Ультразвукове дослідження таза, або – 55812-00 Ультразвукове дослідження грудної клітки або черевної стінки.	
IR.4.02	Ультразвукове дослідження сечовивідних шляхів (код 55038-00) Дослідження потрапляє у звітність на оплату при дотриманні таких умов: (а) виконане ультразвукове дослідження сечовивідних шляхів; (б) упродовж 24 годин, які передують його проведенню, пацієнту не виконували дослідження з кодами: – 55036-00 Ультразвукове дослідження черевної порожнини або – 55065-00 Ультразвукове дослідження таза, або – 55812-00 Ультразвукове дослідження грудної клітки або черевної стінки.	1.09.2025
IR.4.03	Ультразвукове дослідження таза (код 55065-00) Дослідження потрапляє у звітність на оплату при дотриманні таких умов: (а) виконане ультразвукове дослідження органів таза; (б) упродовж 24 годин, які передують його проведенню, пацієнту не виконували дослідження з кодами: – 55038-00 Ультразвукове дослідження сечовивідних шляхів або – 55036-00 Ультразвукове дослідження черевної порожнини.	1.09.2025
IR.4.04	УЗД сечового міхура (код 55084-00) Дослідження потрапляє у звітність на оплату при дотриманні таких умов: (а) виконане ультразвукове дослідження сечового міхура; (б) упродовж 24 годин, які передують його проведенню, пацієнту не виконували дослідження з кодами: – 11917-00 Цистометрографія з 1 або більше вимірюванням або – 55038-00 Ультразвукове дослідження сечовивідних шляхів або – 55036-00 Ультразвукове дослідження черевної порожнини або – 55065-00 Ультразвукове дослідження таза.	1.09.2025

Клас «УЛЬТРАЗВУКОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ» (IR.4.)

Група 2. СЕРЦЕ
(коди 55113-00, 55118-00)

Номер правила	Правило	Дата запровадження/зміни/скасування
IR.4.05	Одновимірне (М-режим) та двовимірне ультразвукове дослідження серця у реальному часі (код 55113-00) Дослідження потрапляє у звітність на оплату при дотриманні таких умов: (а) проведене дослідження щонайменше з 2 акустичних вікон, з вимірюванням швидкості кровотоку через серцеві клапани за допомогою методів імпульсного та безперервного доплера, та кольоровим картуванням потоку в реальному часі щонайменше з 2 акустичних вікон, із записами цифровому носії (за вимогою пацієнта) - для дослідження симптомів або ознак серцевої недостатності, або підозрюваної чи відомої гіпертрофії чи дисфункції шлуночків, або болю в грудях.	1.09.2025
IR.4.06	Двовимірне черезстравохідне ультразвукове дослідження серця у реальному часі (код 55118-00) Дослідження потрапляє у звітність на оплату при дотриманні таких умов: (а) проведене черезстравохідне ультразвукове дослідження серця в реальному часі; (б) пацієнту, якому проводилося діагностичне дослідження, одночасно не надавалися послуги з кодом: – 55113-00 Одновимірне (М-режим) та двовимірне ультразвукове дослідження серця у реальному часі. Дослідження може потребувати анестезіологічного забезпечення.	1.09.2025

Клас «УЛЬТРАЗВУКОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ» (IR.4.)

Група 3. СУДИНИ

(коди 55238-00, 55238-01, 55244-00, 55244-01, 55248-00, 55248-01, 55252-00, 55252-01, 55274-00, 55276-00, 55278-00, 55280-00, 55282-00, 55284-00, 55292-00, 55292-01, 55294-00, 55294-01, 55294-02)

Номер правила	Правило	Дата запровадження/зміни/скасування

IR.4.07	У разі вказання кодів однобічного та двобічного дослідження судин в ЕМЗ, що сформовані упродовж одного дня – оплата здійснюється як за одне дослідження.	1.09.2025
IR.4.08	Якщо лікар надає 2 або більше послуг ультразвукового дослідження судин в межах групи 3 одному пацієнту в той самий день, плата за кожне наступне дослідження судин, зменшується на 40%.	1.09.2025
IR.4.09	Ультразвукове дуплексне дослідження вен нижньої кінцівки, однобічне (коди пункту 55244) Дослідження потрапляє у звітність на оплату при дотриманні таких умов: (а) проведено дуплексне сканування, одностороннє, що включає ультразвукову візуалізацію в режимі В та інтегровані доплерівські вимірювання потоку шляхом спектрального аналізу вен нижньої кінцівки (нижче пахової зв'язки) для виявлення гострого венозного тромбозу.	1.09.2025
IR.4.10	Ультразвукове дуплексне дослідження позачерепних, каротидних та вертебральних судин (код 55274-00) Дослідження потрапляє у звітність на оплату при дотриманні таких умов: (а) проведено дуплексне сканування, двостороннє, що включає ультразвукову візуалізацію в режимі В та інтегровані доплерівські вимірювання потоку за допомогою спектрального аналізу екстракраніальних двосторонніх сонних та хребетних судин, з підключичними та безіменними судинами або без них, з окулоплетизмографією або периорбітальним доплерівським дослідженням або без них.	1.09.2025
IR.4.11	Ультразвукове дуплексне дослідження ниркових та/або вісцеральних судин (код 55278-00) Дослідження потрапляє у звітність на оплату при дотриманні таких умов: (а) проведено дуплексне сканування, що включає ультразвукову візуалізацію в В-режимі та інтегровані доплерівські вимірювання потоку за допомогою спектрального аналізу ниркових або вісцеральних судин, або ниркових та вісцеральних судин, включаючи аорту, нижню порожнисту вену та клубові судини, за необхідності.	1.09.2025
IR.4.12	Ультразвукове дуплексне дослідження артерії статевого члена (код 55282-00)	1.09.2025

	Дослідження потрапляє у звітність на оплату при дотриманні таких умов: (а) проведено дуплексне сканування, що включає ультразвукову візуалізацію в В-режимі та інтегровані доплерівські вимірювання потоку шляхом спектрального аналізу кавернозної артерії пеніса після внутрішньокавернозного введення вазоактивного агента; та виконується упродовж періоду фармакологічної активності введенного агента для підтвердження діагнозу судинної етіології імпотенції та (б) проведено спеціалістом з УЗД, урології, з судинної хірургії та (с) упродовж 24 годин, які передують його проведенню, пацієнту не виконували дослідження з кодом: – 55284-00 Ультразвукове дуплексне дослідження печеристого тіла статевго члена	
IR.4.13	Ультразвукове дуплексне дослідження печеристого тіла статевго члена (код 55284-00) Дослідження потрапляє у звітність на оплату при дотриманні таких умов: (а) проведено дуплексне сканування, що включає ультразвукову візуалізацію в В-режимі та інтегровані доплерівські вимірювання потоку за допомогою спектрального аналізу кавернозної тканини пеніса для підтвердження діагнозу та, де показано, для оцінки перебігу та лікування: – пріапізму; або – фіброзу будь-якого типу або – перелому tunica albuginea або – артеріовенозних мальформацій; (б) проведено спеціалістом з УЗД, урології, з судинної хірургії та (с) упродовж 24 годин, які передують його проведенню, пацієнту не виконували дослідження з кодом: – 55282-00 Ультразвукове дуплексне дослідження артерії статевго члена.	1.09.2025

Клас «УЛЬТРАЗВУКОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ» (IR.4.)

Група 4. УРОЛОГІЯ (Код 55600-00)

Номер правила	Правило	Дата запровадження/зміни/скасування

IR.4.14	Ультразвукове дослідження передміхурової залози, основи сечового міхура та сечівника (код 55600-00) Дослідження потрапляє у звіт на оплату при дотриманні таких умов: а) проведено ультразвукове дослідження простати з використанням одного або кількох датчиків-перетворювачів, які можуть отримувати як аксіальне, так і сагітальне сканування у 2 площинах під прямим кутом та (б) пацієнту, якого направив спеціаліст з урології, радіаційної онкології або онкології, який: – обстежив пацієнта упродовж 60 днів до сканування та – рекомендував сканування для лікування поточного захворювання простати пацієнта.	1.09.2025
----------------	--	-----------

Клас «УЛЬТРАЗВУКОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ» (IR.4.)

Група 5. АКУШЕРСТВО

(код 55700-00)

Номер правила	Правило	Дата запровадження/зміни/скасування
IR.4.15	Дослідження групи 5 «Акушерство» потрапляють у звіт на оплату при дотриманні таких умов: (а) направлення на дослідження видане лікарем-спеціалістом; (б) дослідження виконане лікарем, які пройшли навчання і відповідно до своїх посадових обов'язків мають право проводити такі дослідження (коди посад P149,P150,P151,P34).	1.09.2025
IR.4.16	Ультразвукове дослідження для виявлення аномалій плода (код 55700-00) Дослідження потрапляє у звіт на оплату при дотриманні таких умов: (а) проведено ультразвукове дослідження, під час якого оцінено розвиток плода та його анатомію, будь-яким або всіма доступами; (б) направлення на дослідження видане лікарем акушером-гінекологом з метою експертного дослідження; (в) вагітність (підтверджена ультразвуком) датується куприково-тім'яною довжиною від 45 до 84 мм;	1.09.2025

	(г) лікар, який направляє жінку та лікар, який проводить дослідження вагітної не є співробітниками одного закладу; (д) присутній один або декілька з наступних станів: — гіперемезис вагітних, або — цукровий діабет, або — гіпертонія, або — токсикоз вагітних, або — захворювання печінки або нирок, або — аутоімунне захворювання, або — захворювання ССС, або — алоїмунізація, або — материнська інфекція, або — запальне захворювання кишечника, або — стома кишечника, або — рубці на черевній стінці, або — попередня травма або захворювання хребта або тазу, або — залежність від наркотиків та інших психотропних препарат та речовин, або — тромбофілія, або — значне ожиріння у матері, або — вік матері >35 років, або — біль у животі або утворення, або — невизначена дата, або — вагітність високого ризику, або — попередні переношені вагітності, або — попередній кесарів розтин, або — ускладнений акушерський анамнез, або — підозра на позаматкову вагітність, або — ризик викидня, або — зменшення симптомів вагітності, або — підозрювана або відома цервікальна недостатність, або — підозрювана або відома аномалія матки, або — вагітність після допоміжних репродуктивних технологій, або — ризик аномалій плода.	
--	---	--

Клас «УЛЬТРАЗВУКОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ» (ІР.4.)

Група 6. СКЕЛЕТНО-М'ЯЗОВА СИСТЕМА

(коди 55812-00, 55816-00, 55816-01, 55844-00, 55852-00, 90908-01)

Номер правила	Правило	Дата запровадження/зміни/ скасування
IR.4.17	Дослідження цієї групи потрапляють у звіт на оплату при дотриманні таких умов: (а) направлення на дослідження видане сімейним лікарем (крім кодів 55844-00, 55852-00, 90908-01) або лікарем-спеціалістом (всі коди); (б) дослідження виконане лікарем, який пройшов навчання і відповідно до своїх посадових обов'язків має право проводити такі дослідження, зокрема коди посад (P149,P93,P94).	1.09.2025
IR.4.18	Ультразвукове дослідження грудної клітки або черевної стінки (код 55812-00) Дослідження потрапляє у звіт на оплату при дотриманні таких умов: (а) виконане ультразвукове сканування грудної клітки або стінки черевної порожнини, та (б) пацієнту, якому проводилося діагностичне дослідження, одночасно не надавалися послуги з кодами: – 55070-00 Ультразвукове дослідження молочної залози, однобічне, або – 55076-00 Ультразвукове дослідження молочної залози, двобічне.	1.09.2025
IR.4.19	Ультразвукове дослідження ділянки кульшового суглоба або пахвинної ділянки (пункт 55816) Дослідження потрапляє у звіт на оплату при дотриманні таких умов: (а) виконане ультразвукове сканування кульшового суглоба або пахвинної ділянки, з однієї або двох сторін та (б) пацієнту, якому проводилося діагностичне дослідження, одночасно не надавалися послуги з кодом: – 55065-00 Ультразвукове дослідження таза.	1.09.2025
IR.4.20	Ультразвукове дослідження шкіри та підшкірної тканини (код 55844-00) Дослідження потрапляє у звіт на оплату при дотриманні таких умов: (а) виконано оцінку утворення, пов'язаного зі шкірою або підшкірними структурами, яке не є частиною м'язово-рухової системи, ультразвукове сканування однієї або більше ділянок та	1.09.2025

	(б) пацієнту, якому проводилося діагностичне дослідження, одночасно не надавалися послугами, зазначеними у групах 1 або 3 класу «Ультразвукові дослідження».	
IR.4.21	Ультразвукове дослідження хребта та спинного мозку (код 55852-00) Дослідження потрапляє у звіт на оплату при дотриманні таких умов: (а) виконано ультразвукове сканування хребта, спинного мозку і підлеглих підшкірних тканин.	1.09.2025

КЛАС «КЛІНІЧНІ ІНСТРУМЕНТАЛЬНІ ДОСЛІДЖЕННЯ» (IR.5.)

Номер правила	Правило	Дата запровадження/зміни/скасування
IR.5.0	Дослідження потрапляє у звіт на оплату при дотриманні таких умов: (а) дослідження виконане за направленням лікаря-спеціаліста або сімейного лікаря (для кодів 11727-00, 11708-00, 11709-00) (б) дослідження виконане лікарем, який пройшов навчання і відповідно до своїх посадових обов'язків має право проводити такі дослідження; (в) лікар, який проводив дослідження, підготував висновок про дослідження, надав пацієнту паперовий або електронний його варіант; (г) лікар, який проводив дослідження, зафіксував скорочений варіант висновку в ЕМЗ «Діагностичний звіт».	1.09.2025

КЛАС «КЛІНІЧНІ ІНСТРУМЕНТАЛЬНІ ДОСЛІДЖЕННЯ» (IR.5.)**Група 1. НЕВРОЛОГІЯ**

(коди 11000-00, 11003-00, 11009-00, 11012-00, 11012-01, 11012-02, 11015-00, 11015-01, 11018-00, 11018-01, 11018-02, 11021-00, 11021-01, 11021-02, 11024-00, 11027-00, 92011-00)

Номер правила	Правило	Дата запровадження/зміни / скасування
IR.5.01	Електроенцефалографія (код 11000-00), Дослідження потрапляє у звіт на оплату при дотриманні таких умов: (а) проведено електроенцефалографію тривалістю до трьох годин; (б) упродовж 24 годин, які передують його проведенню, пацієнту не виконували дослідження з кодами: – 11003-00 Електроенцефалографія тривалістю ≥ 3 годин або – 11009-00 Електрокортикографія	1.09.2025
IR.5.02	Електроенцефалографія (код 11003-00), запис тривалістю не менше 3 годин.	1.09.2025

	Дослідження потрапляє у звіт на оплату при дотриманні таких умов: (а) проведено електроенцефалографію, тривалістю не менше 3 годин,; (б) пацієнту, якому проводилося діагностичне дослідження, одночасно не надавалися послуги з кодами: – 11000-00 Електроенцефалографія або – 11009-00 Електрокортикографія.	
IR.5.03	Електрокортикографія (код 11009-00) Дослідження потрапляє у звіт на оплату при дотриманні таких умов: (а) проведено електрокортикографію: (б) упродовж 24 годин, які передують його проведенню, пацієнту не виконували дослідження з кодом: – 11003-00 Електроенцефалографія тривалістю ≥ 3 годин б) пацієнту, якому проводилося діагностичне дослідження, одночасно не надавалися послуги з кодом: – 11000-00 Електроенцефалографія.	1.09.2025
IR.5.04	Електроенцефалографічний [ЕЕГ] відео- та радіотелеметричний моніторинг (код 92011-00) Дослідження потрапляє у звіт на оплату при дотриманні таких умов: (а) проведено електроенцефалографічний [ЕЕГ] відео- та радіотелеметричний моніторинг тривалістю ≥ 24 годин; б) пацієнту, якому проводилося діагностичне дослідження, одночасно не надавалися послуги з кодом: – 11003-00 Електроенцефалографія тривалістю ≥ 3 годин або – 11000-00 Електроенцефалографія, або – 11009-00 Електрокортикографія.	1.09.2025
IR.5.05	Електроміографія [ЕМГ] (коди пункту 11012) Дослідження потрапляє у звіт на оплату при дотриманні таких умов: (а) проведено електронейроміографічне дослідження по 1 нерву або електроміографічне дослідження одного	1.09.2025

	або більше м'язів з використанням концентричних голчастих електродів АБО обидва ці обстеження; (б) упродовж 24 годин, які передують його проведенню, пацієнту не виконували дослідження з кодами: – пункту 11015 Дослідження проведення по 2 або 3 нервам або – пункту 11018 Дослідження проведення по ≥ 4 нервам або – іншим кодом пункту 11012.	
IR.5.06	Дослідження проведення по 2 або 3 нервам (коди пункту 11015) Дослідження потрапляє у звіт на оплату при дотриманні таких умов: (а) проведено електронейроміографічне дослідження по 2 або 3 нервам з електроміографічним дослідженням або без нього; (б) упродовж 24 годин, які передують його проведенню, пацієнту не виконували дослідження з кодами: – пункту 11012 Дослідження по 1 нерву та електроміографія або – пункту 11018 Дослідження проведення по ≥ 4 нервам або – іншим кодом пункту 11015.	1.09.2025
IR.5.07	Дослідження проведення по ≥ 4 нервам (коди пункту 11018) Дослідження потрапляє у звіт на оплату при дотриманні таких умов: (а) проведено електронейроміографічне дослідження по 4 нервам та більше з електроміографічним дослідженням або без нього АБО записи з окремих волокон нервів і м'язів АБО обидва ці дослідження; (б) упродовж 24 годин, які передують його проведенню, пацієнту не виконували дослідження з кодами – коди пункту 11012 Дослідження по 1 нерву та електроміографія або – коди пункту 11015 Дослідження проведення по 2 або 3 нервам або – іншим кодом пункту 11018.	1.09.2025
IR.5.08	Повторні дослідження нервово-м'язової провідності (коди пункту 11021)	1.09.2025

	Дослідження потрапляє у звіт на оплату при дотриманні таких умов: (а) повторна стимуляція для електронейроміографічного дослідження або електроміографічного дослідження з кількісним комп'ютерним аналізом АБО обидва ці дослідження б) упродовж 24 годин, які передують його проведенню, пацієнту не виконували дослідження з кодами – 11012-02 Дослідження проведення по 1 нерву з електроміографією або – 11015-01 Дослідження проведення по 2 або 3 нервам з електроміографією або – 11018-01 Дослідження проведення по ≥ 4 нервам з електроміографією або – іншим кодом пункту 11021.	
IR.5.09	Вивчення викликаного потенціалу центральної нервової системи, 1 або 2 дослідження (код 11024-00) Дослідження потрапляє у звіт на оплату при дотриманні таких умов: (а) досліджено один або два усереднених зразки електричної активності, записаних з одного або двох місць у центральній нервовій системі у відповідь на той самий або інший стимул; б) упродовж 24 годин, які передують його проведенню, пацієнту не виконували дослідження з кодом: – 11027-00 Вивчення викликаного потенціалу центральної нервової системи, ≥ 3 досліджень	1.09.2025
IR.5.10	Вивчення викликаного потенціалу центральної нервової системи, ≥ 3 досліджень (код 11027-00) Дослідження потрапляє у звіт на оплату при дотриманні таких умов: (а) досліджено три або більше усереднених зразків електричної активності, записаних з різних місць у центральній нервовій системі у відповідь на різні стимули; б) упродовж 24 годин, які передують його проведенню, пацієнту не виконували дослідження з кодом: – 11024-00 Вивчення викликаного потенціалу центральної нервової системи, 1 або 2 дослідження.	1.09.2025

КЛАС «КЛІНІЧНІ ІНСТРУМЕНТАЛЬНІ ДОСЛІДЖЕННЯ» (ІР.5.)**Група 2. ОФТАЛЬМОЛОГІЯ**

(коди 11200-00, 11204-00, 11205-00, 11210-00, 11215-00, 11218-00, 11221-00, 11224-00, 11235-00, 11240-01)

Номер правила	Правило	Дата запровадження/зміни/скасування
ІР.5.11	Інтервенції наведені нижче входять у комплексну послугу класу «Офтальмологія» сервісу «Консультування та лікування», тому оплата відбувається в межах даного класу Перелік інтервенцій включає: 96038-00 Вимірювання гостроти зору 96039-00 Тест на контрастну чутливість 92018-00 Перевірка кольорового зору 11211-00 Перевірка адаптації очей до темноти 96040-00 Ручна периметрія, однобічна 96041-00 Ручна периметрія, двобічна 96042-00 Вимірювання акомодації 96043-00 Вимірювання рефракції 92016-00 Тонометрія 96044-00 Вимірювання рухів очного яблука та бінокулярної функції	1.09.2025
ІР.5.12	Провокаційні проби для виявлення глаукоми (код 11200-00) Дослідження потрапляє у звіт на оплату при дотриманні таких умов: (а) виконано провокаційну пробу АБО пробу при відкрито-кутовій глаукомі (код Н40.1 Первинна відкритокутова глаукома), включаючи пиття води	1.09.2025
ІР.5.13	Електроретинографія (код 11204-00) Дослідження потрапляє у звіт на оплату при дотриманні таких умов: (а) виконано електроретинографію одного або обох очей за допомогою комп'ютеризованих методів усереднення, включаючи 3 або більше досліджень.	1.09.2025
ІР.5.14	Електроокулографія (код 11205-00) Дослідження потрапляє у звіт на оплату при дотриманні таких умов: (а) виконано електроокулографію одного або обох очей.	1.09.2025

IR.5.15	Паттерн-електроретинографія (код 11210-00) Дослідження потрапляє у звіт на оплату при дотриманні таких умов: (а) виконано Паттерн-електроретинографію <i>одного або обох очей</i> за допомогою комп'ютерних методів усереднення, включаючи 3 або більше досліджень,	1.09.2025
IR.5.16	Фотографування сітківки 1 ока (код 11215-00) Дослідження потрапляє у звіт на оплату при дотриманні таких умов: (а) виконано ангіографію сітківки одного ока, що включає багаторазову експозицію 1 ока з внутрішньовенною ін'єкцією контрасту; (б) упродовж 24 годин, які передують його проведенню, пацієнту не виконували дослідження з кодом: – 11218-00 Фотографування сітківки обох очей.	1.09.2025
IR.5.17	Фотографування сітківки обох очей (код 11218-00) Дослідження потрапляє у звіт на оплату при дотриманні таких умов: (а) виконано ангіографію сітківки обох очей, що включає багаторазову експозицію обох очей з внутрішньовенною ін'єкцією контрасту; (б) упродовж 24 годин, які передують його проведенню, пацієнту не виконували дослідження з кодом: – 11215-00 Фотографування сітківки 1 ока.	1.09.2025
IR.5.18	Повна кількісна комп'ютеризована периметрія, двобічна (код 11221-00) Дослідження потрапляє у звіт на оплату при дотриманні таких умов: (а) виконано повну кількісну комп'ютеризовану периметрію двобічну, пацієнту з наявним захворюванням очей або підозрою на патологію зорових шляхів або головного мозку; б) пацієнту за останні 12 місяців виконано не більше 1 діагностичного дослідження (усього два рази за 12 місяців) кодами: – 11221-00 Повна кількісна комп'ютеризована периметрія, двобічна та – 11224-00 Повна кількісна комп'ютеризована периметрія.	1.09.2025
IR.5.19	Повна кількісна комп'ютеризована периметрія (код 11224-00)	1.09.2025

	Дослідження потрапляє у звіт на оплату при дотриманні таких умов: (а) виконано повну кількісну комп'ютеризовану периметрію однобічну, пацієнту з наявним захворюванням очей або підозрою на патологію зорових шляхів або головного мозку; б) пацієнту за останні 12 місяців виконано не більше 1 діагностичного дослідження (усього два рази за 12 місяців) кодами: – 11221-00 Повна кількісна комп'ютеризована периметрія, двобічна та – 11224-00 Повна кількісна комп'ютеризована периметрія.	
IR.5.21	Обстеження ока за допомогою імпресійної цитології рогівки (код 11235-00) Дослідження потрапляє у звіт на оплату при дотриманні таких умов (а) виконано обстеження ока за допомогою імпресійної цитології рогівки для дослідження дисплазії поверхні ока, включаючи збір клітин, обробку	1.09.2025
IR.5.22	Інтерферометрія з частковою когерентністю (код 11240-01) Дослідження потрапляє у звіт на оплату при дотриманні таких умов: (а) виконано одновимірну ультразвукову ехографію або часткову когерентну інтерферометрію для дослідження одного ока перед операцією на кришталику на цьому оці, включає лазерну доплерівську інтерферометрію, вимірювання аксіальної довжини ока.	1.09.2025

КЛАС «КЛІНІЧНІ ІНСТРУМЕНТАЛЬНІ ДОСЛІДЖЕННЯ» (IR.5.)

Група 3. ОТОЛАРИНГОЛОГІЯ

(коди 11300-00, 11303-00, 11304-00, 11306-00, 11309-00, 11309-01, 11312-00, 11312-02, 11315-01, 11324-00, 11324-01, 11332-00, 11332-01, 11332-02, 11333-00, 11336-00, 11339-00, 96063-00)

Номер правила	Правило	Дата запровадження/зміни/скасування
IR.5.23	Аудіологічні послуги - (пункти 11309 - 11318)	1.09.2025

	Медична послуга, зазначена в пунктах 11309 - 11318, вважається медичною послугою для цілей виплати за ПМГ, якщо вона надається: (а) в умовах, що дозволяють встановити певні порогові значення; (б) у приміщенні з ослабленим звуком та фоновим шумом та (в) з використанням каліброваного обладнання.	
IR.5.24	Нижче вказані інтервенції входять у комплексну послугу класу «Аудіологія» сервісу «Консультування та лікування», тому оплата відбувається в межах даного класу. Перелік інтервенцій включає: 96045-00 Мовний -тест з перевертанням 96046-00 Дихотичний тест з прослуховуванням спондеїчних слів [ПСС] 96047-00 Тест з використанням фільтрованого мовлення 96048-00 Тест виділення семантично неоднорідних фраз [BCP] 96049-00 Тест на злиття (складів чи звуків) 96173-00 Аудіометрія електричної слухової реакції стовбура головного мозку 96050-00 Аудіометрія реакції, викликаной корою головного мозку 96051-00 Стаціонарні викликані потенціали 96052-00 Поріг акустичного рефлексу 96053-00 Розпад акустичного рефлексу 96054-00 Тест на дисфункцію євстахієвої труби 96055-00 Індекс чутливості до коротких наростань звука (ІЧКН-тест) 96056-00 Тест перемінного бінаурального балансу гучності (ПББГ-тест) 96057-00 Тест на різницю рівнів з маскуванням 96058-00 Тест на згасання порогового тону 96059-00 Інші психоакустичні тести 96065-00 Співставлення шуму у вухах або маскування звуку 92026-00 Дослідження функції носа (Риноманометрія)	1.09.2025
IR.5.25	Аудіометрія викликаной реакції стовбура головного мозку (код 11300-00) Дослідження потрапляє у звіт на оплату при дотриманні таких умов:	1.09.2025

	(а) виконано аудіометрію викликаної реакції стовбура головного мозку. Дослідження може потребувати анестезіологічного забезпечення	
IR.5.26	Екстратимпанальна електрокохлеографія (код 11303-00) Дослідження потрапляє у звіт на оплату при дотриманні таких умов: (а) виконано екстратимпанальну електрокохлеографію, однобічну або двобічну	1.09.2025
IR.5.27	Транстимпанальна електрокохлеографія (код 11304-00) Дослідження потрапляє у звіт на оплату при дотриманні таких умов: (а) виконано транстимпанальну електрокохлеографію, однобічну або двобічну з введенням електродів через барабанну перетинку (якщо проводиться).	1.09.2025
IR.5.28	Інша аудіометрія (код 11306-00) Дослідження потрапляє у звіт на оплату при дотриманні таких умов (а) виконано скринінгову аудіометрію, що охоплює одну або декілька послуг, зазначених кодами пунктів 11309-11315, коли вони не виконуються за умовами, викладеними в правилах до кодів пункту 11332.	1.09.2025
IR.5.29	Аудіометричне дослідження повітряної провідності, (коди пункту 11309) Дослідження потрапляє у звіт на оплату при дотриманні таких умов: (а) виконано аудіограму: повітряну провідність	1.09.2025
IR.5.30	Аудіометричне дослідження повітряної та кісткової провідності (коди пункту 11312) Дослідження потрапляє у звіт на оплату при дотриманні таких умов: (а) виконано аудіограму: повітряну та кісткову провідність або повітряну провідність та розрізнення мовлення; (б) упродовж 24 годин, які передують його проведенню, пацієнту не виконували дослідження з кодами: – Пункту 11309 Аудіометричне дослідження повітряної провідності або – 11315-01 Тест розпізнавання мовлення.	1.09.2025
IR.5.31	Тест розпізнавання мовлення (код 11315-01)	1.09.2025

	Дослідження потрапляє у звіт на оплату при дотриманні таких умов: (а) виконано аудіограму: тест розпізнавання мовлення	
IR.5.32	Тимпанометрія зі стандартним зондуємим тоном (коди пункту 11324) Дослідження потрапляє у звіт на оплату при дотриманні таких умов: (а) виконано імпедансну аудіограму, що включає тимпанометрію, вимірювання статичної податливості та акустичний рефлекс.	1.09.2025
IR.5.33	Оцінка отоакустичної емісії (коди пункту 11332) Дослідження потрапляє у звіт на оплату при дотриманні таких умов (а) оцінено отоакустичну емісію у немовляти чи дитини, які знаходяться в групі ризику через один або більше з таких факторів: -госпіталізація до відділення інтенсивної терапії новонароджених або -порушення слуху в сімейному анамнезі, або -внутрішньоутробна або перинатальна інфекція (підозрювана або підтверджена), або -вага при народженні менше 1,5 кг, або -черепно-лицьова деформація, або -асфіксія при народженні, або -хромосомна аномалія, включаючи синдром Дауна, або -замінне переливання крові. (б) пацієнт направлений іншим лікарем; (в) за висновком лікаря-спеціаліста патологія середнього вуха виключено; (д) дослідження проводиться поза межами планового скринінгу немовлят.	1.09.2025
IR.5.34	Калорична проба лабіринту (код 11333-00) Дослідження потрапляє у звіт на оплату при дотриманні таких умов: (а) виконано калоричну пробу лабіринту.	1.09.2025
IR.5.35	Одночасна подвійна калорична проба лабіринту (код 11336-00) Дослідження потрапляє у звіт на оплату при дотриманні таких умов: (а) виконано одночасну подвійну калоричну пробу лабіринту.	1.09.2025
IR.5.36	Електроністагмографія (код 11339-00) Дослідження потрапляє у звіт на оплату при дотриманні таких умов:	1.09.2025

	(а) виконано електроністагмографію	
IR.5.37	Оцінка вестибулярної функції на кріслі, що обертається (кріслі Барані) (код 96063-00) Дослідження потрапляє у звіт на оплату при дотриманні таких умов: (а) оцінено вестибулярну функцію на кріслі, що обертається (кріслі Барані)	1.09.2025

КЛАС «КЛІНІЧНІ ІНСТРУМЕНТАЛЬНІ ДОСЛІДЖЕННЯ» (IR.5.)

Група 4. ОРГАНИ ДИХАННЯ

(коди 11503-00, 11503-01, 11503-02, 11503-03, 11503-04, 11503-05, 11503-06, 11503-07, 11503-08, 11503-09, 11503-10, 11503-11, 11503-12, 11503-13, 11503-14, 11503-15, 11503-16, 11503-17, 11503-18, 11503-19, 11506-00, 11512-00)

Номер правила	Правило	Дата запровадження/зміни/скасування
IR.5.38	Комплексне дослідження функції дихання, включаючи оцінювання функції легень та дихальних м'язів, яке проводиться в спеціально обладнаній лабораторії для проведення таких досліджень, на перевіреному метрологом обладнанні	1.09.2025
IR.5.39	Комплексне вимірювання респіраторної функції, включаючи легені та дихальні м'язи (коди пункту 11503) Дослідження потрапляє у звіт на оплату при дотриманні таких умов: (а) виконано будь-який з наступних тестів – вимірювання дифузійної здатності монооксиду вуглецю будь-яким методом; – вимірювання опору дихальних шляхів або легень будь-яким методом; – інгаляційний провокаційний тест, включаючи спірометрію до провокації та побудову кривої дози-відповіді, використовуючи визнаний прямий або непрямий бронхопровокаційний агент і спірометрію після бронходилататора; – інгаляційний провокаційний тест, що включає спірометрію до провокації та побудову кривої дози-відповіді, з використанням визнаного прямого або непрямого бронхопровокаційного агента та спірометрію після бронхолітатора;	1.09.2025

- спірометрія, що виконується до та після простого тесту з фізичним навантаженням, проведеного як провокаційний тест для дослідження астми, у приміщеннях, обладнаних реанімаційним обладнанням та персоналом, навченим Advanced Life Support;
- вимірювання сили м'язів вдиху та видиху при кількох легеневих об'ємах;
- імітований висотний тест, що включає вплив гіпоксичних газових сумішей і насичення киснем у стані спокою та/або під час фізичних навантажень з або без спостереження ефекту додаткового кисню;
- розрахунок легеневого або серцевого шунта шляхом вимірювання парціального тиску кисню в артеріальній крові та концентрації гемоглобіну після вдихання з концентрацією кисню 100% упродовж 15 хвилин або більше.

(б) упродовж 24 годин, які передують його проведенню, пацієнту не виконували дослідження з кодами:

- 11506-00 Інші вимірювання респіраторної функції
- 11512-00 Безперервне вимірювання співвідношення між потоком та об'ємом під час видихання або вдихання

Примітка. Коди пункту 11503 не призначені для дослідження порушень сну. Дані, отримані в рамках дослідження сну в діапазоні 12203-12250, не можуть бути використані для вказання кодів пункту 11503.

Якщо безперервне вимірювання співвідношення між потоком та об'ємом під час видихання або вдихання (код 11512-00) проводиться в той самий день, що й діагностична послуга з кодом пункту 11503, вказувати потрібно лише код 11503.

Тестування максимального циклу потоку-об'єму на вдиху та видиху з метою діагностики обструкції центральних дихальних шляхів має позначатися кодом 11512, а не 11503.

Якщо безперервне вимірювання співвідношення між потоком та об'ємом під час видихання або вдихання є єдиним лабораторним тестом, що проводиться, тоді необхідно заявити 11512-00.

IR.5.40	Інші вимірювання респіраторної функції (код 11506-00) Дослідження потрапляє у звіт на оплату при дотриманні таких умов: (а) проведено спірометрію, що передбачає постійне дослідження, виконане до і після інгаляції бронходилататора; і виконується для: – підтвердження діагнозу хронічного обструктивного захворювання легень (ХОЗЛ) або – оцінювання загострення астми, або – моніторингу астми та ХОЗЛ, або – встановлення інших причин обструктивного захворювання легень або наявності рестриктивного захворювання легень. (б) упродовж 24 годин, які передують його проведенню, пацієнту не виконували дослідження з кодами: – 11512-00 Безперервне вимірювання співвідношення між потоком та об'ємом під час видихання або вдихання – 11503 комплексне вимірювання респіраторної функції, включаючи легені та дихальні м'язи	1.09.2025
IR.5.41	Безперервне вимірювання співвідношення між потоком та об'ємом під час видихання або вдихання (код 11512-00) Дослідження потрапляє у звіт на оплату при дотриманні таких умов: (а) проведено безперервне вимірювання співвідношення між потоком та об'ємом під час видиху або під час видиху та вдиху, що виконується до та після інгаляції бронходилататора; та для якого виконується 3 або більше спірометричних записів; (б) упродовж 24 годин, які передують його проведенню, пацієнту не виконували дослідження з кодом: – Пункту 11503 комплексне вимірювання респіраторної функції, включаючи легені та дихальні м'язи	1.09.2025

КЛАС «КЛІНІЧНІ ІНСТРУМЕНТАЛЬНІ ДОСЛІДЖЕННЯ» (IR.5.)

Група 5. СУДИНИ

(коди 11600-00, 11600-01, 11600-02, 11600-03, 11602-00, 11604-00, 11605-00, 11610-00,

Номер правила	Правило	Дата запровадження/зміни/скасування
IR.5.42	Моніторинг артеріального тиску (центрального венозного, легеневого артеріального, системного артеріального або серцевого внутрішньопорожнинного) (коди пункту 11600) Дослідження потрапляє у звіт на оплату при дотриманні таких умов: (а) проведено моніторинг артеріального тиску за допомогою постійного катетера - тільки один раз для кожного типу тиску в будь-який календарний день, максимум до 4 типів артеріального тиску	1.09.2025
IR.5.43	Обстеження та фіксування форми хвилі периферичних вен в одній або кількох кінцівках у стані спокою за допомогою CW-доплера або імпульсної доплеровської РЛС (код 11602-00) Дослідження потрапляє у звіт на оплату при дотриманні таких умов: (а) проведено дослідження венозного рефлюксу або обструкції в одній або кількох кінцівках у стані спокою за допомогою безперервного доплера або імпульсного доплера, що включає обстеження в кількох місцях вздовж кожної кінцівки з використанням періодичного стиснення кінцівки або проб Вальсальви, або обох, для виявлення прогресуючого та ретроградного кровотоку, (б) пацієнту, якому проводилося діагностичне дослідження, одночасно не надавалися послуги з кодами: – 32500-00 Мікроін'єкції в ділянки з розширенням венул або – 32500-01 Декілька ін'єкцій у варикозні вени; (в) пацієнту за останні 12 місяців виконано не більше 1 діагностичного дослідження з даним кодом (усього два рази за 12 місяців).	1.09.2025
IR.5.44	Обстеження та фіксування форми хвилі периферичних вен у 1 або декількох кінцівках за допомогою плетизмографії (код 11604-00) Дослідження потрапляє у звіт на оплату при дотриманні таких умов: (а) проведено плетизмографію (за винятком фотоплетизмографії) однієї або кількох кінцівок особі	1.09.2025

	з хронічним венозним захворюванням верхніх і нижніх кінцівок; (б) пацієнту, якому проводилося діагностичне дослідження, одночасно не надавалися послуги з кодами: – 32500-00 Мікроін'єкції в ділянки з розширенням венул або – 32500-01 Декілька ін'єкцій у варикозні вени.	
IR.5.45	Обстеження та фіксування форми хвилі периферичних вен у нижніх кінцівках під час та після фізичного навантаження з використанням інфрачервоної фотоплетизмографії (код 11605-00) Дослідження потрапляє у звіт на оплату при дотриманні таких умов: (а) проведено інфрачервону фотоплетизмографію однієї або кількох кінцівок особі зі складним хронічним рефлюксом або обструкцією нижніх кінцівок під час і після фізичних вправ для визначення показань для хірургічного втручання або консервативного лікування тромботичної хвороби глибоких вен; (б) пацієнту, якому проводилося діагностичне дослідження, одночасно не надавалися послуги з кодами: – 32500-00 Мікроін'єкції в ділянки з розширенням венул або – 32500-01 Декілька ін'єкцій у варикозні вени.	1.09.2025
IR.5.46	Вимірювання показників систолічного артеріального тиску з обох сторін та оцінка форм хвилі у артеріях нижніх кінцівок (код 11610-00) Дослідження потрапляє у звіт на оплату при дотриманні таких умов: (а) проведено двобічне визначення кісточно-плечових індексів та аналіз артеріальних хвиль, вимірювання тиску в задньому великогомілковому та тильному м'язах стопи (або пальці стопи) та плечовій артерії за допомогою доплерівських або плетизмографічних методів, для оцінки захворювання артерій нижніх кінцівок	1.09.2025
IR.5.47	Вимірювання показників систолічного артеріального тиску з обох сторін та оцінка форм хвилі у артеріях верхніх кінцівок (код 11611-00) Дослідження потрапляє у звіт на оплату при дотриманні таких умов:	1.09.2025

	(а) проведено двобічне вимірювання радіального та ліктьового (або пальцевого) і плечового артеріального тиску за допомогою доплерівської або плетизмографічної техніки, розрахунок індексів систолічного тиску на зап'ясті або пальці-плечовій артерії та аналіз артеріальних хвиль для оцінки захворювання артерій верхніх кінцівок.	
IR.5.48	Вимірювання показників систолічного артеріального тиску з обох сторін у стані спокою та після фізичного навантаження у нижніх кінцівках (код 11612-00) Дослідження потрапляє у звіт на оплату при дотриманні таких умов: (а) проведено двобічне вимірювання артеріального тиску в задній великогомілковій і спинній м'язах стопи (або пальця стопи) і плечового артеріального тиску за допомогою доплерівської або плетизмографічної техніки, розрахунок індексів систолічного тиску в гомілковостопному відділі (або пальці стопи) - плечового суглоба для оцінки захворювання артерій нижніх кінцівок у стані спокою та після вправ за допомогою бігової доріжки або велоергометра або іншого подібного обладнання, де робоче навантаження піддається кількісному документуванню; (б) пацієнту, якому проводилося діагностичне дослідження, одночасно не надавалися послуги з кодом – 11610-00 Вимірювання показників систолічного артеріального тиску з обох сторін та оцінка форм хвилі у артеріях нижніх кінцівок	1.09.2025
IR.5.49	Обстеження та фіксування форми хвилі потоку крові у внутрішньочерепних артеріях за допомогою транскраніального доплера (код 11614-00) Дослідження потрапляє у звіт на оплату при дотриманні таких умов: (а) проведено обстеження внутрішньочерепного артеріального кровообігу за допомогою CW доплера або імпульсного доплера із записом форм хвилі; (б) упродовж 24 годин, які передують його проведенню, пацієнту не виконували дослідження з кодом: – 55280-00 Ультразвукове дуплексне дослідження внутрішньочерепних судин	1.09.2025

КЛАС «КЛІНІЧНІ ІНСТРУМЕНТАЛЬНІ ДОСЛІДЖЕННЯ» (IR.5.)

Група 6. СЕРЦЕВО-СУДИННА СИСТЕМА

(код 11700-00, 11708-00, 11709-00, 11712-00, 11713-00, 11721-03, 11727-00)

Номер правила	Правило	Дата запровадження/зміни/скасування
IR.5.50	Інша електрокардіографія [ЕКГ] (код 11700-00) Дослідження потрапляє у звіт на оплату при дотриманні таких умов: (а) проведено електрокардіографію у 12 відведеннях	1.09.2025
IR.5.51	Амбулаторне безперервне записування результатів ЕКГ (код 11708-00) Дослідження потрапляє у звіт на оплату при дотриманні таких умов: (а) проведено безперервний запис ЕКГ амбулаторного пацієнта упродовж 12 або більше годин (включаючи ЕКГ у стані спокою та запис параметрів), не пов'язаний з амбулаторним моніторингом артеріального тиску, із залученням мікропроцесорного аналізуючого обладнання; (б) упродовж 24 годин, які передують його проведенню, пацієнту не виконували дослідження з кодом – 11709 Холтерівське амбулаторне безперервне записування результатів ЕКГ	1.09.2025
IR.5.52	Холтерівське амбулаторне безперервне записування результатів ЕКГ (код 11709) Дослідження потрапляє у звіт на оплату при дотриманні таких умов: (а) проведено безперервний запис ЕКГ (Холтер)в пацієнта упродовж 12 або більше годин (включаючи ЕКГ у спокої та запис параметрів), не пов'язаний з амбулаторним моніторингом артеріального тиску, з використанням системи, здатної до накладання та повного роздрукування записаних даних ЕКГ щонайменше за 12 годин, мікропроцесорного аналізу сканування з інтерпретацією.	1.09.2025
IR.5.53	Велоергометрія (код 11712-00) Дослідження потрапляє у звіт на оплату при дотриманні таких умов:	1.09.2025

	(а) проведено багатоканальний моніторинг та запис ЕКГ під час тренування (моторизована бігова доріжка або велоергометр, здатний кількісно визначати зовнішнє робоче навантаження у ватах) або фармакологічний стрес, що передбачає безперервну присутність лікаря упродовж не менше ніж 20 хвилин, з ЕКГ у спокої та з або без постійного моніторингу артеріального тиску та записом інших параметрів, у приміщенні, обладнаного механічними респіраторами та дефібриляторами	
IR.5.54	Запис усереднених сигналів ЕКГ (<i>код 11713-00</i>) Дослідження потрапляє у звіт на оплату при дотриманні таких умов: (а) проведено дослідження з реєстрації усередненого сигналу ЕКГ, що включає не більше 300 ударів, використовуючи принаймні 3 відведення зі збором даних принаймні 100 комплексів QRS на частоті не менше 1000 Г.	1.09.2025
IR.5.55	Тестування послідовного атріовентрикулярного, частотно-адаптивного або антитахікардіального кардіостимулятора (<i>код 11721-03</i>) Дослідження потрапляє у звіт на оплату при дотриманні таких умов: (а) проведено тестування імплантованих атріовентрикулярних (AV) послідовних, частотно-чутливих або антитахікардійних кардіостимуляторів, включаючи перепрограмування за потреби; (б) пацієнту, якому проводилося діагностичне дослідження, одночасно не надавалися послуги з кодами: – 11727-00 Тестування кардіодефібрилятора або – 11700-00 Інша електрокардіографія [ЕКГ].	1.09.2025
IR.5.56	Тестування кардіодефібрилятора (<i>код 11727-00</i>) Дослідження потрапляє у звіт на оплату при дотриманні таких умов: (а) проведено тестування імплантаційного дефібрилятора, що включає електрокардіографію, оцінку стимуляції та порогових значень для електродів стимуляції та дефібриляції, завантаження та інтерпретацію збережених подій та електрограм, у тому числі програмування за потреби,	1.09.2025

	(б) пацієнту, якому проводилося діагностичне дослідження, одночасно не надавалися послуги з кодами: – 11700-00 Інша електрокардіографія [ЕКГ] або – 11721-03 Тестування послідовного атріовентрикулярного, частотно-адаптивного або антитахікардіального кардіостимулятора.	
--	---	--

КЛАС «КЛІНІЧНІ ІНСТРУМЕНТАЛЬНІ ДОСЛІДЖЕННЯ» (IR.5.)

Група 7. ГАСТРОЕНТЕРОЛОГІЯ

(коди 11800-00, 11810-00, 11830-00, 11830-02, 11833-00, 11833-01)

Номер правила	Правило	Дата запровадження/зміни/скасування
IR.5.57	Перевірка моторики стравоходу (код 11800-00) Дослідження потрапляє у звіт на оплату при дотриманні таких умов: (а) виконано тест з перевірки моторики стравоходу, манометричний	1.09.2025
IR.5.58	Вимірювання шлунково-стравохідного рефлюксу з використанням моніторингу рН упродовж 24 годин (код 11810-00) Дослідження потрапляє у звіт на оплату при дотриманні таких умов: (а) виконано клінічну оцінку гастро-езофагеальної рефлюксної хвороби за допомогою 24-годинного рН моніторингу, включаючи аналіз, інтерпретацію та звіт, а також будь-які відповідні консультації	1.09.2025
IR.5.59	Аноректальна манометрія (коди 11830-00, 11830-02) Дослідження потрапляє у звіт на оплату при дотриманні таких умов: (а) виконано анальну манометрію або виміряно чутливість аноректальної зони або виміряно ректосфінктерний рефлекс для діагностики порушень тазового дна.	1.09.2025
IR.5.60	Вимірювання моторного латентного періоду соромітного та спинномозкового нервів (коди 11833-00, 11833-01) Дослідження потрапляє у звіт на оплату при дотриманні таких умов (а) виконано електроміографію або вимірювання моторного латентного періоду соромітного та	1.09.2025

	спинномозкового нервів для діагностики порушень м'язів тазового дна та анального сфінктера	
--	--	--

КЛАС «КЛІНІЧНІ ІНСТРУМЕНТАЛЬНІ ДОСЛІДЖЕННЯ» (IR.5.)

Група 8. СТАТЕВІ ОРГАНИ/СЕЧОВИВІДНІ ШЛЯХИ

(коди 11900-00, 11912-00, 11917-00, 11919-00)

Номер правила	Правило	Дата запровадження/зміни/скасування
IR.5.61	Вивчення сечовипускання (код 11900-00) Дослідження потрапляє у звіт на оплату при дотриманні таких умов: (а) досліджено сечовипускання, включаючи вимірювання пікової швидкості сечовипускання, урофлоуметрію; (б) упродовж 24 годин, які передують його проведенню, пацієнту не виконували дослідження з кодом – 11919-00 Цистометрографія з контрастною мікційною цистоуретерографією	1.09.2025
IR.5.62	Цистометрографія з вимірюванням тиску у прямій кишці (код 11912-00) Дослідження потрапляє у звіт на оплату при дотриманні таких умов: (а) здійснено цистометрографію з одночасним вимірюванням тиску у прямій кишці; (б) упродовж 24 годин, які передують його проведенню, пацієнту не виконували дослідження з кодами – 11019-00 Цистометрографія з контрастною мікційною цистоуретерографією Може потребувати анестезіологічного забезпечення	1.09.2025
IR.5.63	Цистометрографія з 1 або більше вимірюванням (код 11917-00) Дослідження потрапляє у звіт на оплату при дотриманні таких умов: (а) здійснено цистометрографію з вимірюванням одного або більше показників: швидкості потоку сечі, профілю уретрального тиску, ректального тиску, електроміографії, сфінктера уретри; включаючи всю візуалізацію, пов'язану з цистометрографією; (б) упродовж 24 годин, які передують його проведенню, пацієнту не виконували дослідження з кодами – 11012-00 Цистометрографія з вимірюванням тиску у прямій кишці	1.09.2025

	– 11900-00 Вивчення сечовипускання – 11919-00 Цистометрографія з контрастною мікційною цистоуретерографією Дослідження може потребувати анестезіологічного забезпечення (сервіс «Процедури»)	
IR.5.64	Цистометрографія з мікційною (контрастною) цистоуретерографією (код 11919-00) Дослідження потрапляє у звіт на оплату при дотриманні таких умов: (а) здійснено цистометрографію в поєднанні з міктурацією контрасту, з вимірюванням одного або більше показників: швидкості потоку сечі, профілю уретрального тиску, ректального тиску, електроміографії уретрального сфінктера; включаючи всю візуалізацію, пов'язану з цистометрографією, (б) упродовж 24 годин, які передують його проведенню, пацієнту не виконували дослідження з кодами – 11012-00 Цистометрографія з вимірюванням тиску у прямій кишці або – 11900-00 Вивчення сечовипускання, або – 11917-00 Цистометрографія з 1 або більше вимірюванням. Дослідження може потребувати анестезіологічного забезпечення (сервіс «Процедури»)	1.09.2025

КЛАС «КЛІНІЧНІ ІНСТРУМЕНТАЛЬНІ ДОСЛІДЖЕННЯ» (IR.5.)

Група 9. ТЕСТИ НА АЛЕРГІЮ

(коди 12000-00, 12003-00, 12012-00, 12018-00, 12021-00)

Номер правила	Правило	Дата запровадження/зміни/скасування
IR.5.65	Шкірні тести на алергію (пункти 12000-12005) Дослідження потрапляє у звіт на оплату при дотриманні таких умов: (а) дослідження проведене в медичному закладі, який оснащений відповідним обладнанням для реанімації, і в якому працюють лікарі компетентні в лікуванні системних алергічних реакцій; (б) дослідження проведене лікарем-спеціалістом, який має кваліфікацію та досвід у всіх аспектах проведення шкірних тестів на алергію.	1.09.2025
IR.5.66	Шкірно-алергічна проба з використанням ≤ 20 алергенів (код 12000-00)	1.09.2025

	Дослідження потрапляє у звіт на оплату при дотриманні таких умов: (а) виконано шкірний тест на наявність алергенів, включаючи всі алергени, протестовані в один день, б) упродовж 24 годин, які передують його проведенню, пацієнту не виконували дослідження з кодами: – 12012-00 Тестування нашкірним пластиром, використовуючи менше ніж загальна кількість алергенів у стандартному наборі для алергічної проби або – 12003-00 Шкірно-алергічна проба з використанням ≥ 21 алергену, або – 12021-00 Тестування нашкірним пластиром, використовуючи ≥ 51 алергену, або – 12018-00 Тестування нашкірним пластиром, використовуючи ≤ 50 алергенів.	
IR.5.67	Шкірно-алергічна проба з використанням ≥ 21 алергену (код 12003-00) Дослідження потрапляє у звіт на оплату при дотриманні таких умов: (а) виконано шкірний тест на харчові та латексні алергени, включаючи всі алергени, перевірені в один день; б) упродовж 24 годин, які передують його проведенню, пацієнту не виконували дослідження з кодами: – 12012-00 Тестування нашкірним пластиром, використовуючи менше ніж загальна кількість алергенів у стандартному наборі для алергічної проби або – 12000-00 Шкірно-алергічна проба з використанням ≤ 20 алергенів, або – 12021-00 Тестування нашкірним пластиром, використовуючи ≥ 51 алергену, або – 12018-00 Тестування нашкірним пластиром, використовуючи ≤ 50 алергенів	1.09.2025
IR.5.68	Тестування нашкірним пластиром, використовуючи менше ніж загальна кількість алергенів у стандартному наборі для алергічної проби (код 12012-00) Дослідження потрапляє у звіт на оплату при дотриманні таких умов: (а) виконано патч-тестування при дослідженні алергічного дерматиту з використанням не більше 25 алергенів;	1.09.2025

	б) упродовж 24 годин, які передують його проведенню, пацієнту не виконували дослідження з кодами: – 12003-00 Шкірно-алергічна проба з використанням ≥ 21 алергену або – 12000-00 Шкірно-алергічна проба з використанням ≤ 20 алергенів, або – 12021-00 Тестування на шкірним пластиром, використовуючи ≥ 51 алергену, або – 12018-00 Тестування на шкірним пластиром, використовуючи ≤ 50 алергенів.	
IR.5.69	Тестування на шкірним пластиром, використовуючи ≤ 50 алергенів (код 12018-00) Дослідження потрапляє у звіт на оплату при дотриманні таких умов: (а) виконано патч-тестування при дослідженні алергічного дерматиту з використанням більше 25 алергенів, але не більше 50 алергенів; б) упродовж 24 годин, які передують його проведенню, пацієнту не виконували дослідження з кодами: – 12003-00 Шкірно-алергічна проба з використанням ≥ 21 алергену або – 12000-00 Шкірно-алергічна проба з використанням ≤ 20 алергенів, або – 12021-00 Тестування на шкірним пластиром, використовуючи ≥ 51 алергену, або – 12012-00 Тестування на шкірним пластиром, використовуючи менше ніж загальна кількість алергенів у стандартному наборі для алергічної проби.	1.09.2025
IR.5.70	Тестування на шкірним пластиром, використовуючи ≥ 51 алергену (код 12021-00) Дослідження потрапляє у звіт на оплату при дотриманні таких умов: (а) виконано патч-тестування при дослідженні алергічного дерматиту, з використанням більше 50 алергенів, але не більше 75 алергенів б) упродовж 24 годин, які передують його проведенню, пацієнту не виконували дослідження з кодами: – 12003-00 Шкірно-алергічна проба з використанням ≥ 21 алергену або – 12000-00 Шкірно-алергічна проба з використанням ≤ 20 алергенів, або – 12018-00 Тестування на шкірним пластиром, використовуючи ≤ 50 алергенів, або	1.09.2025

	– 12012-00 Тестування нашкірним пластиром, використовуючи менше ніж загальна кількість алергенів у стандартному наборі для алергічної проби.	
--	--	--

КЛАС «КЛІНІЧНІ ІНСТРУМЕНТАЛЬНІ ДОСЛІДЖЕННЯ» (IR.5.)

Група 10. ІНШІ ДІАГНОСТИЧНІ ПРОЦЕДУРИ ТА ДОСЛІДЖЕННЯ (коди 12203-00, 12306-00)

Номер правила	Правило	Дата запровадження/зміни/скасування
IR.5.71	Полісомнографія (код 12203-00) Дослідження потрапляє у звіт на оплату при дотриманні таких умов: (а) виконано діагностичну оцінку сну тривалістю не менше 8 годин для пацієнта віком від 18 років для підтвердження діагнозу розладу сну, якщо є: – підозра на синдром обструктивного апное сну або – підозра на синдром центрального апное уві сні, або – підозра на синдром гіповентиляції уві сні, або – підозра на розлади дихання, пов'язані зі сном, у зв'язку з нереспіраторними супутніми захворюваннями, включаючи серцеву недостатність, значні серцеві аритмії, неврологічні захворювання, акромегалію або гіпотиреоз, або – нез'ясована гіперсонливість, або – підозра на парасомнію або судомний розлад, коли клінічний діагноз не може бути встановлений лише на основі клінічних ознак (включаючи пов'язані атипові ознаки, поведінку настороженості або відсутність відповіді на традиційну терапію), або – підозра на рухові розлади, пов'язані зі сном, (б) проводиться безперервний моніторинг та запис, таких досліджень: – потік повітря; – електроміографія (якщо проводиться); – безперервний ЕКГ; – безперервний ЕЕГ (якщо проводиться);	1.09.2025

	– насичення киснем; – дихальні рухи (грудної клітки та живота); (в) підготовлено та інтерпретовано звіт кваліфікованим лікарем з медицини сну; (г) пацієнту, якому проводилося діагностичне дослідження, одночасно не надавалися послуги з кодами: – 11000-00 Електроенцефалографія або – 11003-00 Електроенцефалографія тривалістю ≥ 3 годин, або – пункту 11503 Комплексне вимірювання респіраторної функції, включаючи легені та дихальні м'язи, або – 11700-00 Інша електрокардіографія [ЕКГ], або – 11708-00 Амбулаторне безперервне записування результатів ЕКГ, або – 11709-00 Холтерівське амбулаторне безперервне записування результатів ЕКГ або – 11713-00 Запис усереднених сигналів ЕКГ (д) пацієнту за останні 12 місяців діагностичне дослідження з даним кодом при даному стані не проводилося (усього один раз за 12 місяців).	
IR.5.72	Денситометрія з використанням двоенергетичної рентгенівської абсорбціометрії (код 12306-00) Дослідження потрапляє у звіт на оплату при дотриманні таких умов: (а) виконано кісткову денситометрію з використанням рентгенівської абсорбціометрії з подвійною енергією, що включає вимірювання 2 або більше ділянок (включаючи інтерпретацію та звіт) для підтвердження передбачуваного діагнозу низької мінеральної щільності кісткової тканини, поставленого на підставі: – наявності у пацієнта одного або кількох переломів, що сталися після мінімальної травми (кратність обстежень не більше одного разу за 24 місяці); або – отримання пацієнтом тривалої терапії глюкокортикоїдами (кратність обстежень не більше одного разу за 12 місяці) або – суттєвої зміни лікування, або – наявності стану, пов'язаного з надмірною секрецією глюкокортикоїдів (кратність обстежень не більше одного разу за 12 місяці), або	1.09.2025

- наявності чоловічого гіпогонадізму (кратність обстежень не більше одного разу за 12 місяці), або
- наявності жіночого гіпогонадізму, що триває більше 6 місяців в особи віком до 45 років (кратність обстежень не більше одного разу за 12 місяці) або
- наявності первинного гіперпаратиреозу (кратність обстежень не більше одного разу за 24 місяці) або
- наявності хронічного захворювання печінки (кратність обстежень не більше одного разу за 24 місяці) або
- наявності хронічного захворювання нирок (кратність обстежень не більше одного разу за 24 місяці) або
- наявності доведеного синдрому мальабсорбції (кратність обстежень не більше одного разу за 24 місяці) або
- наявності ревматоїдного артриту (кратність обстежень не більше одного разу за 24 місяці), або
- наявності стану, пов'язаного з надлишком тироксину (кратність обстежень не більше одного разу за 24 місяці), або
- для моніторингу низької щільності кісткової тканини, підтвердженої кістковою денситометрією принаймні 12 місяців тому (кратність обстежень не більше одного разу за 12 місяців) або;
- для моніторингу низької щільності кісткової тканини, щонайменше через 12 місяців після суттєвої зміни терапії (кратність обстежень не більше одного разу за 12 місяців) або;
- для моніторингу низької щільності кісткової тканини у пацієнта віком 70 років або більше (первинне скринінгове дослідження з подальшим обстеженням: один раз у кожні 5 років, якщо пацієнт має нормальний результат або легку остеопенію, виміряну за t-показником до -1,5, або один раз у кожні два роки, якщо пацієнт має помірну або виражену остеопенію, що вимірюється за T-балом від -1,5 до -2,5).

Примітка.

	<i>Суттєва зміна терапії</i> - це зміни класу препаратів, а не зміни режиму дозування. <i>Тривала глюкокортикоїдна терапія</i> визначається як терапія тривалістю щонайменше 4 місяці: - з початку прийому дози інгаляційного глюкокортикоїду, еквівалентної або більшої за 800 мікрограмів беклометазону дипропіонату або будесоніду на день; або - з початку прийому дози перорального глюкокортикоїду, еквівалентної або більшої за 7,5 мг преднізолону у дорослої людини на день; <i>Чоловічий гіпогонадизм</i> визначається як рівень тестостерону в сироватці крові нижче за норму для відповідного віку. <i>Жіночий гіпогонадизм</i> визначається як рівень естрогену в сироватці крові нижче за норму для відповідного віку. <i>Синдром мальабсорбції</i> визначається як один або декілька з наступних станів: — мальабсорбція жиру, що визначається як кількість жиру в калових масах, що становить 18 г за 72 години при нормальній жировій дієті; або — захворювання кишечника з ймовірною мальабсорбцією вітаміну D, що підтверджується субнормально низьким рівнем 25-гідроксивітаміну D у крові; або — гістологічно доведена целиакія.	
--	---	--